

Question 1

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Parmi les propositions suivantes concernant les MAPI possibles du vaccin anti coquelucheux , précisez celles qui sont justes :

☐ a.

Un syndrome des cris persistants

☐ b.

Une éruption cutanée non urticarienne 5jours après la vaccination

☐ c.

Un état de choc vagal quelques heures après la vaccination

☐ d.

Une crise convulsive

☐ e.

Une névrite brachiale

Feedback

Les réponses correctes sont : Un syndrome des cris persistants, Un état de choc vagal quelques heures après la vaccination, Une crise convulsive

Question 2

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Parmi les causes possibles d'une hématurie terminale, vous retenez ?

- ☐ a.
une lithiase vésicale
- ☐ b.
une tumeur pyélique
- ☐ c.
un adénome de la prostate
- ☐ d.
un cancer de la prostate
- ☐ e.
une cystite

Feedback

Les réponses correctes sont : une lithiase vésicale,
une cystite

Question 3

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

L'origine de la thyroïdite du post-partum est :

☐ a.

Infectieuse

☐ b.

Carentielle

☐ c.

Toxique

☐ d.

Auto-immune

☐ e.

Idiopathique

Feedback

La réponse correcte est : Auto-immune

Question 4

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une hypothyroïdie périphérique peut s'associer à:

☐ a.

Une hyperuricémie

☐ b.

Une Hypocholestérolémie

☐ c.

Une Anémie

☐ d.

Une hypercalcémie

☐ e.

Une augmentation de TSH

Feedback

Les réponses correctes sont : Une hyperuricémie, Une Anémie, Une augmentation de TSH

Question 5

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

La base du crâne est formée par les structures osseuses suivantes :

☐ a.

L'os pariétal

☐ b.

L'os sphénoïdal

☐ c.

L'os maxillaire

☐ d.

L'os occipital

☐ e.

L'os frontal

Feedback

Les réponses correctes sont : L'os pariétal, L'os sphénoïdal, L'os occipital, L'os frontal

Question 6

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

L'hématome extradural :

☐ a.

Se constitue entre l'arachnoïde et la dure-mère

☐ b.

Sa présentation au scanner est celle d'un croissant

☐ c.

Le diagnostic est suspecté à l'échographie trans-fontanellaire

☐ d.

Sa présentation au scanner est celle d'une lentille biconvexe spontanément hyperdense

☐ e.

L'examen des pupilles montre une anisocorie

Feedback

Les réponses correctes sont : Sa présentation au scanner est celle d'une lentille biconvexe spontanément hyperdense, L'examen des pupilles montre une anisocorie

Question 7

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Au cours de l'intoxication aux organophosphorés :

☐ a.

Il existe une activation de l'activité acétyl-cholinestérasique

☐ b.

La phosphorylation du site estérasique de l'acétylcholinestérase est d'emblée irréversible

☐ c.

Il existe une accumulation d'acétylcholine

☐ d.

Il existe une hydrolyse de l'acétylcholine en choline et en acide acétique

☐ e.

Certains organophosphorés peuvent phosphoryler une protéine du système nerveux central, la neuropathytargetesterase (NTE)

Feedback

Les réponses correctes sont : Il existe une accumulation d'acétylcholine, Certains organophosphorés peuvent phosphoryler une protéine du système nerveux central, la neuropathytargetesterase (NTE)

Question 8

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) peut survenir suite à :

☐ a.

Une combustion complète d'une matière carbonée en présence d'oxygène

☐ b.

La survenue d'un incendie

☐ c.

L'explosion d'une bouteille à gaz

☐ d.

L'exposition à un brasero dans une chambre non aérée.

☐ e.

Une fuite de gaz de ville

Feedback

Les réponses correctes sont : La survenue d'un incendie, L'exposition à un brasero dans une chambre non aérée.

Question 9

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

La maladie de Basedow est :

☐ a.

La première cause d'hyperthyroïdie chez le sujet âgé

☐ b.

Plus fréquente chez la femme

☐ c.

Associée à une orbitopathie dans plus de 90% des cas

☐ d.

Associée à une scintigraphie blanche

☐ e.

Associée à un taux effondré de thyroglobuline

Feedback

La réponse correcte est : Plus fréquente chez la femme

Question 10

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Parmi les affections pancréatiques suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui peut (peuvent) être responsable(s) d'un diabète secondaire ?

☐ a.

La mucoviscidose

☐ b.

L'insulinome

☐ c.

La pancréatite aiguë

☐ d.

Le pancréas divisum

☐ e.

Le gastrinome

Feedback

Les réponses correctes sont : La mucoviscidose, La pancréatite aiguë

Question 11

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une HGPO75, pratiquée chez une femme enceinte à 26 semaines d'aménorrhée, montre :

Glycémie à jeun : 0,96 g/l

Glycémie 1 heure post-charge : 1,74 g/l

Glycémie 2 heures post-charge : 1,42 g/l

Cette patiente présente :

☐ a.

Une intolérance au glucose

☐ b.

Une tolérance glucidique normale

☐ c.

Une seule glycémie pathologique

☐ d.

Un diabète gestationnel

☐ e.

Un prédiabète

Feedback

Les réponses correctes sont : Une seule glycémie pathologique, Un diabète gestationnel

Question 12

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

La ponction articulaire lors d'une suspicion d'arthrite septique de la hanche :

☐ a.

Est indiquée avant l'échographie de la hanche

☐ b.

Est pratiquée au lit du patient

☐ c.

Doit précéder le démarrage d'une antibiothérapie

☐ d.

Renseigne notamment sur l'aspect du liquide articulaire

☐ e.

Peut déboucher immédiatement sur une arthrotomie

Feedback

Les réponses correctes sont : Doit précéder le démarrage d'une antibiothérapie, Renseigne notamment sur l'aspect du liquide articulaire, Peut déboucher immédiatement sur une arthrotomie

Question 13

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les deux virus les plus incriminés dans la bronchiolite aigue du nourrisson sont :

☐ a.

Le rhinovirus

☐ b.

Le virus influenzae

☐ c.

Le virus respiratoire syncitial

☐ d.

Le coronavirus

☐ e.

Le métapneumovirus

Feedback

Les réponses correctes sont : Le rhinovirus, Le virus respiratoire syncitial

Question 14

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Au cours du choc cardiogénique, lesquelles des molécules suivantes peuvent être indiquée :

☐ a.

La noradrénaline

☐ b.

Le lévosimendan

☐ c.

Une corticothérapie systémique

☐ d.

L'adrénaline

☐ e.

Les diurétiques thiazidiques

Feedback

Les réponses correctes sont : La noradrénaline, Le lévosimendan, L'adrénaline

Question 15

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Quels renseignements peut-on tirer de la Pression artérielle pulmonaire d'occlusion (PAPO) ?

☐ a.

Estimation de la post charge du VD

☐ b.

Estimation de la pré-charge du VG

☐ c.

Une PAPO élevée et un débit cardiaque bas est en faveur d'un état de choc hypovolémique

☐ d.

Est un indice de précharge cardiaque

☐ e.

Une PAPO élevée et un débit cardiaque élevée est en faveur d'un état de choc cardiogénique

Feedback

Les réponses correctes sont : Estimation de la pré-charge du VG, Est un indice de précharge cardiaque

Question 16

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant l'hypertrophie bénigne de la prostate, quels sont les propositions justes ?

☐ a.

Il s'agit d'une tumeur bénigne

☐ b.

C'est la maladie la plus fréquente de l'homme vieillissant

☐ c.

elle se développe à partir de la zone périphérique de la prostate

☐ d.

Elle est caractérisée par le développement de plusieurs nodules adéno-fibreux

☐ e.

Peut dégénérer et entraîner un cancer de la prostate

Feedback

Les réponses correctes sont : Il s'agit d'une tumeur bénigne, C'est la maladie la plus fréquente de l'homme vieillissant, Elle est caractérisée par le développement de plusieurs nodules adéno-fibreux

Question 17

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le traitement chirurgical de l'hypertrophie bénigne de la prostate peut se compliquer de :

☐ a.

Saignement post opératoire immédiat

☐ b.

Éjaculation prématurée

☐ c.

Dysfonction érectile organique

☐ d.

Saignement par chute d'escarre

☐ e.

Incontinence urinaire

Feedback

Les réponses correctes sont : Saignement post opératoire immédiat, Saignement par chute d'escarre, Incontinence urinaire

Question 18

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Au cours de la réanimation de l'insuffisance surrénalienne aiguë, l'hydrocortisone :

☐ a.

Est administré par voie intramusculaire ou intraveineuse

☐ b.

Est administré en une seule prise par jour

☐ c.

Doit être associé au fludrocortisone le premier jour

☐ d.

Est prescrit à une dose de 50 mg à 100 mg par jour

☐ e.

Est relayé par la dexaméthazone après la normalisation de la kaliémie

Feedback

La réponse correcte est : Est administré par voie intramusculaire ou intraveineuse

Question 19

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les signes en faveur d'une insuffisance surrénalienne d'origine périphériques sont :

☐ a.

La mélanodermie

☐ b.

L'hypotension orthostatique

☐ c.

L'hyperglycémie

☐ d.

L'hypernatrémie

☐ e.

L'hypokaliémie

Feedback

Les réponses correctes sont : La mélanodermie, L'hypotension orthostatique

Question 20

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant la réabsorption proximale de HCO_3^- :

☐ a.

Elle est sous la dépendance de l'activité de la Na/K ATPase basolatérale

☐ b.

Elle diminue en cas d'acidose

☐ c.

Elle augmente en cas de déshydratation extracellulaire

☐ d.

L'excrétion nette des ions H^+ est nulle au niveau du TCP

☐ e.

Une baisse de la $PaCO_2$ conduit à une diminution de la réabsorption des bicarbonates

Feedback

Les réponses correctes sont : Elle est sous la dépendance de l'activité de la Na/K ATPase basolatérale, Elle augmente en cas de déshydratation extracellulaire, Une baisse de la $PaCO_2$ conduit à une diminution de la réabsorption des bicarbonates

Question 21

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant l'excrétion de la charge acide :

☐ a.

L'acidité titrable est la principale voie d'élimination

☐ b.

Le pH des urines dépend de la concentration des protons

☐ c.

L'excrétion urinaire de NH_4^+ est fixe

☐ d.

L'hyperkaliémie augmente la production de NH_3

☐ e.

Le tampon phosphate constitue la forme majoritaire d'acidité titrable

Feedback

Les réponses correctes sont : Le pH des urines dépend de la concentration des protons, Le tampon phosphate constitue la forme majoritaire d'acidité titrable

Question 22

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant la chaîne de survie lors de la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire :

☐ a.

Le premier maillon consiste en une identification et un appel des secours (alerte)

☐ b.

L'appel du SAMU au 190 fera intervenir une ambulance médicalisée

☐ c.

Evaluer la respiration et la circulation prend généralement 25 à 30 secondes

☐ d.

La présence de gasps est assimilée à une respiration anormale

☐ e.

L'absence de pouls radial signe un arrêt circulatoire

Feedback

Les réponses correctes sont : Le premier maillon consiste en une identification et un appel des secours (alerte), L'appel du SAMU au 190 fera intervenir une ambulance médicalisée, La présence de gasps est assimilée à une respiration anormale

Question 23

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les cellules du nœud auriculo-ventriculaire:

☐ a.

Ne sont pas des cellules contractiles

☐ b.

Sont dépendantes de canaux calcique et sodique rapides

☐ c.

Ont un potentiel d'action long ce qui prolonge leur période réfractaire

☐ d.

N'ont pas de dépolarisation spontanée

☐ e.

Prennent le relais en cas de défaillance du nœud sinusal

Feedback

Les réponses correctes sont : Ne sont pas des cellules contractiles, Ont un potentiel d'action long ce qui prolonge leur période réfractaire, Prennent le relais en cas de défaillance du nœud sinusal

Question 24

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le cancer de la prostate classé T2b :

☐ a.

Découvert devant un taux de P.S.A. pathologique

☐ b.

Cancer touchant plus de la moitié d'un lobe de la prostate sans toucher l'autre lobe

☐ c.

Cancer touchant les 2 lobes de la prostate

☐ d.

Cancer touchant un lobe de la prostate et la vésicule séminale homolatérale

☐ e.

Cancer découvert sur du matériel de résection endoscopique de prostate (plus de 5% réséqué)

Feedback

La réponse correcte est : Cancer touchant plus de la moitié d'un lobe de la prostate sans toucher l'autre lobe

Question 25

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le score de Gleason dans le cancer de la prostate est basé sur :

☐ a.

l'architecture de la tumeur

☐ b.

l'index mitotique

☐ c.

l'invasion vasculaire.

☐ d.

La présence d'un granulome avec des cellules géantes

☐ e.

L'engainement péri-nerveux

Feedback

La réponse correcte est : l'architecture de la tumeur

Question 26

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une patiente âgée de 32 ans, hospitalisée en réanimation, présente à l'examen neurologique une ouverture et fermeture des yeux selon un rythme circadien, une présence de tous les réflexes du tronc et une respiration spontanée.

Par ailleurs, elle n'obéit pas aux ordres et ne réagit pas à la stimulation nociceptive.

La patiente présente :

☐ a.

Un coma

☐ b.

Un état de conscience minimal

☐ c.

Un état d'éveil non-répondant

☐ d.

Une mort encéphalique

☐ e.

Un locked in syndrome

Feedback

La réponse correcte est : Un état d'éveil non-répondant

Question 27

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant les antalgiques de pallier 2 :

☐ a.

Ils ne sont prescrits qu'en deuxième intention (après ceux du pallier 1)

☐ b.

Provoquent souvent une accélération du transit

☐ c.

Possèdent des actions synergiques avec le paracétamol

☐ d.

Induisent une réduction de l'efficacité des AVK

☐ e.

L'association avec la morphine est synergique

Feedback

La réponse correcte est : Possèdent des actions synergiques avec le paracétamol

Question 28

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant les mécanismes de la douleur, relever la (ou les) réponse(s) juste(s) :

☐ a.

Les douleurs mixtes sont des douleurs à la fois nociceptives et psychogènes

☐ b.

Les douleurs par excès de nociception sont dues à un dommage tissulaire

☐ c.

La diminution de la douleur au détournement de l'attention atteste de son caractère psychogène

☐ d.

Les douleurs par excès de nociception ne sont pas influencées par les émotions

☐ e.

Le chlorhydrate de tramadol est efficace sur les douleurs neuropathiques

Feedback

Les réponses correctes sont : Les douleurs par excès de nociception sont dues à un dommage tissulaire, Le chlorhydrate de tramadol est efficace sur les douleurs neuropathiques

Question 29

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le facteur atrial natriurétique (FAN) :

☐ a.

Augmente la filtration glomérulaire

☐ b.

Est stimulé par l'hypervolémie centrale

☐ c.

Augmente la natriurèse par la diminution de la réabsorption de Na au niveau du Tube contourné proximal

☐ d.

Augmente la perméabilité membranaire glomérulaire en agissant sur les cellules mésangiales glomérulaires

☐ e.

Diminue la réabsorption obligatoire de l'eau au niveau du Tube contourné proximal

Feedback

Les réponses correctes sont : Augmente la filtration glomérulaire, Est stimulé par l'hypervolémie centrale, Augmente la natriurèse par la diminution de la réabsorption de Na au niveau du Tube contourné proximal, Augmente la perméabilité membranaire glomérulaire en agissant sur les cellules mésangiales glomérulaires

Question 30

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Lors du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire :

☐ a.

La contraception par une pilule œstro-progestative

☐ b.

Les cellules de la macula densa détectent le contenu tubulaire en NaCl

☐ c.

La sécrétion de rénine est inhibée par l'adénosine

☐ d.

Les cellules des lacis se contractent

☐ e.

L'information passe du tube distal vers le glomérule par un influx nerveux

Feedback

Les réponses correctes sont : Les cellules de la macula densa détectent le contenu tubulaire en NaCl, La sécrétion de rénine est inhibée par l'adénosine

Question 31

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une pression rénale de perfusion à 60 mmHg s'accompagne de :

☐ a.

Une baisse du débit de filtration glomérulaire

☐ b.

Vasoconstriction puissante de l'Artériole afférente

☐ c.

Une augmentation du taux de NaCl dans la lumière tubulaire

☐ d.

Une augmentation de la sécrétion de rénine

☐ e.

Une diminution de l'activité sympathique

Feedback

Les réponses correctes sont : Une baisse du débit de filtration glomérulaire, Une augmentation de la sécrétion de rénine

Question 32

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Patient de 67 ans, présente une otite moyenne qui s'est rapidement associée à une céphalée, vomissements, fièvre et prostration.

Le diagnostic d'une méningite purulente a été retenu. L'interrogatoire note une prise de betalactamines dans les trois derniers mois.

Quelle est la bactérie responsable ?

☐ a.

Streptococcus pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline

☐ b.

Streptococcus pneumoniae de sensibilité conservée à la pénicilline

☐ c.

Listeria monocytogenes

☐ d.

Neisseria meningitidis

☐ e.

Streptococcus pyogenes

Feedback

La réponse correcte est : Streptococcus pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline

Question 33

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le(s) principal(aux) germes uréasiques est(sont):

☐ a.

E.Coli

☐ b.

Streptocoque

☐ c.

Proteus mirabilis

☐ d.

Corynebactrium D2

☐ e.

Serratia

Feedback

Les réponses correctes sont : Proteus mirabilis, Corynebactrium D2, Serratia

Question 34

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une colique néphrétique est dite grave (une ou plusieurs réponses) :

☐ a.

Si associée à une fièvre

☐ b.

Si elle s'accompagne de signe digestif

☐ c.

Si associée à un tableau d'anurie

☐ d.

Si associée à des signes urinaires du bas appareil

☐ e.

Chez le transplanté rénal

Feedback

Les réponses correctes sont : Si associée à une fièvre, Si associée à un tableau d'anurie, Chez le transplanté rénal

Question 35

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les œdèmes généralisés peuvent être expliqués par :

☐ a.

Prise médicamenteuse

☐ b.

Hypothyroïdie

☐ c.

Insuffisance cardiaque

☐ d.

Syndrome de Mikulicz

☐ e.

Dermohypodermite

Feedback

Les réponses correctes sont : Prise médicamenteuse, Hypothyroïdie, Insuffisance cardiaque

Question 36

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Un œdème blanc, mou, prenant le godet chez un sujet âgé édenté et diabétique peut être expliqué par :

☐ a.

Une déshydratation extra cellulaire

☐ b.

Une diminution de la Pression oncotique

☐ c.

Une diminution de la perméabilité capillaire

☐ d.

Une dénutrition

☐ e.

Une hypotension artérielle

Feedback

Les réponses correctes sont : Une diminution de la Pression oncotique, Une dénutrition

Question 37

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Devant une adénopathie cervicale isolée, l'examen à demander pour confirmer une origine toxoplasmique est :

☐ a.

La recherche du parasite au niveau du liquide de ponction ganglionnaire

☐ b.

La recherche d'antigènes toxoplasmiques au niveau du liquide de ponction ganglionnaire

☐ c.

La recherche d'anticorps sériques anti-toxoplasmiques

☐ d.

La recherche d'antigènes toxoplasmiques au niveau du sérum

☐ e.

La recherche de l'ADN parasitaire au niveau du sang

Feedback

La réponse correcte est : La recherche d'anticorps sériques anti-toxoplasmiques

Question 38

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les parasitoses considérées comme des infections sexuellement transmissibles sont :

☐ a.

La gale

☐ b.

La balano-posthite candidosique

☐ c.

La trichomonose uro-génitale

☐ d.

La bilharziose uro-génitale

☐ e.

La phtirose

Feedback

Les réponses correctes sont : La gale, La trichomonose uro-génitale, La phtirose

Question 39

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Est considéré comme traumatisé sévère :

☐ a.

Un patient qui a une fracture des deux jambes après une chute dans un match de football

☐ b.

Un patient heurté par une voiture sur l'autoroute et dont l'examen initial trouve une déformation isolée de la jambe gauche

☐ c.

Un patient défénestré (chute du 3ème étage) mais dont l'examen clinique initial semble normal

☐ d.

Un accidenté de la voie publique dont le bilan lésionnel complet à l'hôpital montre une fracture de la 3ème et 4ème côtes droites et une fracture du bassin

☐ e.

Un conducteur présentant une plaie du scalp suite à un avp ayant entraîné le décès du passager avant

Feedback

Les réponses correctes sont : Un patient heurté par une voiture sur l'autoroute et dont l'examen initial trouve une déformation isolée de la jambe gauche, Un patient défénestré (chute du 3ème étage) mais dont l'examen clinique initial semble normal, Un accidenté de la voie publique dont le bilan lésionnel complet à l'hôpital montre une fracture de la 3ème et 4ème côtes droites et une fracture du bassin, Un conducteur présentant une plaie du scalp suite à un avp ayant entraîné le décès du passager avant

Question 40

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Parmi ces indications, les quelles nécessitent une intubation oro-trachéale immédiate en cas de polytraumatisme ?

☐ a.

Détresse circulatoire

☐ b.

Détresse neurologique avec un GCS $\leq$ 8

☐ c.

Patient traumatisé avec un arrachement de membre

☐ d.

En cas de brûlure de la face

☐ e.

Détresse respiratoire en rapport avec un pneumothorax

Feedback

Les réponses correctes sont : Détresse neurologique avec un GCS $\leq$ 8, Patient traumatisé avec un arrachement de membre, En cas de brûlure de la face

Question 41

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Chez une femme de 62 ans, l'apparition de douleurs inflammatoires progressives des épaules avec enraidissement douloureux associées à des radiographies normales, doit faire évoquer 2 diagnostics parmi les suivants :

☐ a.

Goutte

☐ b.

Spondylarthrite

☐ c.

Tendinopathie

☐ d.

Polyarthrite rhumatoïde

☐ e.

Pseudopolyarthrite rhizomélique

Feedback

Les réponses correctes sont : Polyarthrite rhumatoïde, Pseudopolyarthrite rhizomélique

Question 42

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Devant le tableau de polyarthrite rhumatoïde récente, isolée chez une femme de 27 ans, les explorations suivantes sont toutes justifiées d'emblée sauf une, laquelle :

☐ a.

Radiographie articulaire

☐ b.

Recherche du facteur rhumatoïde

☐ c.

Radiographie du thorax

☐ d.

Tomodensitométrie des sacro-iliaques

☐ e.

Recherche des Ac anti-nucléaires

Feedback

La réponse correcte est : Tomodensitométrie des sacro-iliaques

Question 43

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les anticorps anti-CCP sont :

☐ a.

De mauvais pronostic quand ils sont positifs à titre élevé

☐ b.

Dirigés contre des peptides riches en citrulline

☐ c.

Très spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde

☐ d.

Très peu sensibles

☐ e.

Dosés en routine en technique ELISA

Feedback

Les réponses correctes sont : De mauvais pronostic quand ils sont positifs à titre élevé, Dirigés contre des peptides riches en citrulline, Très spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, Dosés en routine en technique ELISA

Question 44

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le purpura vasculaire de mécanisme non inflammatoire peut être dû à :

☐ a.

Une Constitution de microthrombi dans la lumière vasculaire

☐ b.

Des anomalies qualitatives des plaquettes

☐ c.

Un dépôt de complexes immuns

☐ d.

Une migration d'embols

☐ e.

Une fragilité vasculaire secondaire à une amylose

Feedback

Les réponses correctes sont : Une Constitution de microthrombi dans la lumière vasculaire, Une migration d'embols, Une fragilité vasculaire secondaire à une amylose

Question 45

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les pathologies pouvant causer un purpura vasculaire sont :

☐ a.

Lupus érythémateux systémique

☐ b.

Hépatite virale C

☐ c.

Connectivite mixte

☐ d.

Cancer du poumon

☐ e.

Hypovitaminose A

Feedback

Les réponses correctes sont : Lupus érythémateux systémique, Hépatite virale C, Connectivite mixte, Cancer du poumon

Question 46

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

La métallo-protéase ADAMTS13 clive spécifiquement :

☐ a.

Le Facteur VII de la coagulation

☐ b.

Le Fibrinogène

☐ c.

Le plasminogène

☐ d.

Le Facteur Willebrand

☐ e.

Le Facteur VIII

Feedback

La réponse correcte est : Le Facteur Willebrand

Question 47

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les situations pouvant se manifester par un purpura thrombopathique sont :

☐ a.

La maladie de Bernard Soulier

☐ b.

L'Insuffisance rénale chronique

☐ c.

L'Insuffisance hépato-cellulaire

☐ d.

Purpura post transfusionnel

☐ e.

La prise d'AINS

Feedback

Les réponses correctes sont : La maladie de Bernard Soulier, L'Insuffisance rénale chronique, L'Insuffisance hépato-cellulaire, La prise d'AINS

Question 48

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le phénotype D partiel :

☐ a.

Anomalie quantitative de l'antigène RHD

☐ b.

Immunogène

☐ c.

Peut être découvert suite à une discordance dans le groupage Rhésus D

☐ d.

Peut être découvert suite à la découverte d'un anticorps anti D chez un sujet D négatif

☐ e.

Exprimé à la surface des plaquettes

Feedback

Les réponses correctes sont : Immunogène, Peut être découvert suite à une discordance dans le groupage Rhésus D

Question 49

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Le test de Coombs direct est :

☐ a.

Test globulaire

☐ b.

Test en deux temps

☐ c.

Nécessite l'usage d'antiglobuline

☐ d.

Indiqué dans l'enquête d'un accident transfusionnel de type allergique

☐ e.

Indiqué dans l'enquête d'un accident transfusionnel de type hémolyse

Feedback

Les réponses correctes sont : Test globulaire, Nécessite l'usage d'antiglobuline, Indiqué dans l'enquête d'un accident transfusionnel de type hémolyse

Question 50

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Les hémolysines sont :

☐ a.

Dangereux en transfusion

☐ b.

Des Anticorps naturels

☐ c.

De nature IgM

☐ d.

Traversent la barrière foetoplacentaire

☐ e.

Peu hémolysants

Feedback

Les réponses correctes sont : Dangereux en transfusion, Traversent la barrière foetoplacentaire

Question 51

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Concernant l'action de l'aldostérone au niveau du tubule rénal, quelle(s) est (sont) la (les) propositions qui sont exactes :

☐ a.

L'aldostérone stimule l'antiport Na/H au niveau du tube contourné proximal afin d'augmenter la réabsorption du sodium

☐ b.

L'aldostérone stimule les canaux potassique ROMK au niveau de la branche ascendante large de l'anse de henlé

☐ c.

L'aldostérone augmente l'activité de canal épithélial sodique au niveau de la cellule principale

☐ d.

L'aldostérone stimule la pompe H/K ATP asique au niveau de la cellule intercalaire A

☐ e.

L'aldostérone stimule directement les canaux potassiques au niveau de la cellule intercalaire B

Feedback

La réponse correcte est : L'aldostérone augmente l'activité de canal épithélial sodique au niveau de la cellule principale

Question 52

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une acidose métabolique avec une hyperkaliémie s'observe au cours de :

☐ a.

Vomissements abondants

☐ b.

Insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/m

☐ c.

Diarrhée

☐ d.

Une insuffisance surrénalienne

☐ e.

Un traitement par diurétique de l'anse

Feedback

Les réponses correctes sont : Insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/m, Une insuffisance surrénalienne

Question 53

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Parmi les propositions suivantes, précisez celles qui sont justes :

☐ a.

Le vaccin anti coquelucheux acellulaire est un vaccin inactivé

☐ b.

Le vaccin anti rabique est un vaccin vivant atténué

☐ c.

Le vaccin anti pneumococcique (PVC10) est un vaccin recombinant

☐ d.

Le vaccin anti rotavirus est un vaccin vivant atténué

☐ e.

Le vaccin anti diphtérique est une anatoxine

Feedback

Les réponses correctes sont : Le vaccin anti rotavirus est un vaccin vivant atténué, Le vaccin anti diphtérique est une anatoxine

Question 54

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mr x, âgé de 30 ans hypertendu sous aldomet, consulte pour syndrome anémique fonctionnel avec ictère évoluant depuis une semaine.

A l'examen, pâleur cutanéomuqueuse avec ictère franc. Il a une SMG à 3cm. L'état hémodynamique est stable.

NFS : GB : 12000/mm³ (9000 de PNN)

Hb : 6g/dl, VGM : 82fl, Réticulocytes : 140000/mm³

Plq : 540000/mm³

Bilirubine totale : 40mmol/l (VN < 15mmol/l), Bilirubine directe : 7mmol/l

LDH : 500U/l (VN : 180U/l)

Créat : 60μmol/l

1/ Quels sont les arguments en faveur de l'hémolyse intratissulaire ? :

☐ a.

Triade : pâleur, ictère et splénomégalie

☐ b.

Hybilirubinémie libre

☐ c.

Anémie régénérative

☐ d.

Thrombocytose

☐ e.

Elévation des LDH

Feedback

Les réponses correctes sont : Triade : pâleur, ictère et splénomégalie, Hybilirubinémie libre, Élévation des LDH

Question 55

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Quels sont les deux examens à demander afin de préciser le mécanisme de cette anémie hémolytique ? :

☐ a.

Frottis sanguin

☐ b.

Test de Coombs direct

☐ c.

Dosage de l'haptoglobine

☐ d.

Electrophorèse de l'hémoglobine

☐ e.

Myélogramme

Feedback

Les réponses correctes sont : Frottis sanguin, Test de Coombs direct

Question 56

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Le diagnostic d'une anémie hémolytique auto-immune est retenu. Quelle est l'étiologie la plus probable ? :

☐ a.

Idiopathique

☐ b.

Prise médicamenteuse

☐ c.

Infection virale

☐ d.

Transfusion

☐ e.

Maladie de système

Feedback

La réponse correcte est : Prise médicamenteuse

Question 57

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

4/ Quelle serait votre conduite à tenir ? :

☐ a.

Arrêt de l'aldomet

☐ b.

Transfusion

☐ c.

Corticothérapie

☐ d.

Supplémentation en folates

☐ e.

Abstention

Feedback

Les réponses correctes sont : Arrêt de l'aldomet, Supplémentation en folates

Question 58

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mr Y, de 70 ans suivi pour ACFA sous traitement adressé par son cardiologue pour prise en charge d'une anémie.

A l'examen, le patient est pâle, tachycarde à 100bpm et polyénique à 28C/mn. Des OMI ont été objectivés. Il n'y a pas de syndrome tumoral.

NFS : GB : 4500/mm³ (PNN : 2100/mm³)

Hb : 7g/dl, VGM : 90fl, Rétic : 65000/mm³

Plq : 110000/mm³

Créat : 70μmol/l

Bilan hépatique normal

Dosage vitamine B12 et Folates normal

1/ Devant ce tableau, quel est le diagnostic le plus probable ? :

☐ a.

Syndrome myélodysplasique

☐ b.

Carence en vitamine B12

☐ c.

Carence en Folates

☐ d.

Hépatopathie chronique

☐ e.

Insuffisance rénale

Feedback

La réponse correcte est : Syndrome myélodysplasique

Question 59

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Quel est l'examen à réaliser pour confirmer le diagnostic ? :

☐ a.

Myélogramme

☐ b.

Frottis sanguin

☐ c.

Dosage de l'haptoglobine

☐ d.

Test de Coombs direct

☐ e.

Electrophorèse de l'Hb

Feedback

La réponse correcte est : Myélogramme

Question 60

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Il s'agit d'un syndrome myélodysplasique, quelle serait votre conduite à tenir ? :

☐ a.

Transfusion en urgences devant les signes d'insuffisance cardiaque droite

☐ b.

Corticothérapie

☐ c.

Supplémentation en fer

☐ d.

Supplémentation vitaminique

☐ e.

Abstention

Feedback

La réponse correcte est : Transfusion en urgences devant les signes d'insuffisance cardiaque droite

Question 61

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Un patient âgé de 30 ans est victime d'un accident de sport entraînant une fracture ouverte de la jambe droite.

L'examen retrouve une déformation de la jambe avec une plaie de 01 cm simple non contuse en regard de la déformation.

La radiographie de la jambe montre une fracture spiroïde médio-diaphysaire du tibia et une fracture du col de la fibula.

1/ Cette fracture ouverte de jambe :

☐ a.

Est une fracture ouverte de dehors en dedans

☐ b.

Est une fracture ouverte de dedans en dehors

☐ c.

Est classée Cauchoix et Duparc I

☐ d.

Est classée Cauchoix et Duparc II

☐ e.

Est à haut risque de lésion nerveuse

Feedback

Les réponses correctes sont : Est une fracture ouverte de dedans en dehors, Est classée Cauchoux et Duparc I, Est à haut risque de lésion nerveuse

Question 62

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Le traitement à faire aux urgences :

☐ a.

Démarrer une antibiothérapie

☐ b.

Sérothérapie et vaccination antitétanique

☐ c.

Un parage de la plaie

☐ d.

Un lavage abondant de la plaie

☐ e.

La mise en place d'un fixateur externe

Feedback

Les réponses correctes sont : Démarrer une antibiothérapie, Sérothérapie et vaccination antitétanique, Un lavage abondant de la plaie

Question 63

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Vous décidez d'opérer le patient 04 heures après son traumatisme, le traitement à faire au bloc opératoire :

☐ a.

Un parage et une suture de la plaie

☐ b.

La mise en place d'un fixateur externe

☐ c.

Une ostéosynthèse par un clou centromédullaire

☐ d.

La confection d'un plâtre cruro-pédieux

☐ e.

Un lambeau de couverture de la perte de substance cutanée

Feedback

Les réponses correctes sont : Un parage et une suture de la plaie, Une ostéosynthèse par un clou centromédullaire, Un lambeau de couverture de la perte de substance cutanée

Question 64

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

4/ Deux jours après l'intervention, lors de la visite, vous suspectez un syndrome aigu des loges, les signes cliniques en faveur sont :

☐ a.

Une abolition des pouls distaux

☐ b.

Une bradycardie

☐ c.

Une douleur à l'extension des orteils

☐ d.

Une tension excessive du mollet

☐ e.

Des paresthésies au niveau des orteils

Feedback

Les réponses correctes sont : Une douleur à l'extension des orteils, Une tension excessive du mollet, Des paresthésies au niveau des orteils

Question 65

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

MNourrisson de 18 mois amené par ses parents pour refus d'appui du côté droit depuis 24h.

A l'examen, température à 39°C, état général conservé, impotence fonctionnelle du membre inférieur droit avec douleur à la mobilisation de la hanche.

1/ Devant ce tableau quels sont les diagnostics les plus probables ? :

☐ a.

Rhume de la hanche

☐ b.

Arthrite septique de la hanche

☐ c.

Rhumatisme articulaire aigue

☐ d.

Ostéomyélite du col fémoral

☐ e.

Arthrite inflammatoire de la hanche

Feedback

Les réponses correctes sont : Arthrite septique de la hanche, Ostéomyélite du col fémoral

Question 66

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Quels sont les examens complémentaires que vous demandez en première intention :

☐ a.

Radiographie du bassin

☐ b.

Bilan inflammatoire (NFS, VS, CRP)

☐ c.

Un dosage des ASLO

☐ d.

Une scintigraphie osseuse

☐ e.

Une IRM

Feedback

Les réponses correctes sont : Radiographie du bassin, Bilan inflammatoire (NFS, VS, CRP)

Question 67

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Le nourrisson a un syndrome inflammatoire biologique, le bilan d'imagerie de première intention est sans anomalies.

L'échographie a montré un épanchement au niveau de la hanche droite de grande abondance

Quelle est votre conduite thérapeutique ? :

☐ a.

Hémoculture

☐ b.

Surveillance du patient à domicile avec prescription d'anti pyrétiq

☐ c.

Ponction articulaire

☐ d.

Mettre l'enfant sous traitement antibiotique par voie orale

☐ e.

Prescription de corticoïde

Feedback

Les réponses correctes sont : Hémoculture, Ponction articulaire

Question 68

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Nourrisson âgé de 2 mois, ancien prématuré de 32 SA, est hospitalisé pour premier épisode de dyspnée sifflante.

A l'examen physique :

Apyrétique

FR :70 c/min

Sao2 90%

Signes de lutte marqués

Auscultation pulmonaire : râles sibilants diffus au niveau des 2 champs pulmonaires

1/ Quels sont les critères d'hospitalisation pour ce nourrisson ?

☐ a.

Le terrain

☐ b.

L'âge

☐ c.

La fréquence respiratoire

☐ d.

La saturation en O2

☐ e.

La tolérance digestive

Feedback

Les réponses correctes sont : Le terrain, L'âge, La fréquence respiratoire, La saturation en O2

Question 69

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Une radiographie de thorax a été pratiquée, que peut-t-elle montrer ?

☐ a.

Une atélectasie

☐ b.

Une distension thoracique

☐ c.

Une asymétrie de transparence

☐ d.

Une cardiomégalie

☐ e.

Un pneumothorax

Feedback

Les réponses correctes sont : Une atélectasie, Une distension thoracique

Question 70

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Quel est le traitement à proposer pour ce nourrisson ?

☐ a.

Oxygénothérapie par lunettes nasales haut débit

☐ b.

Oxygénothérapie par lunettes nasales simples

☐ c.

Désobstruction nasale

☐ d.

Nébulisation d'adrénaline

☐ e.

Nébulisation de sérum salé hypertonique

Feedback

Les réponses correctes sont : Oxygénothérapie par lunettes nasales haut débit, Oxygénothérapie par lunettes nasales simples, Désobstruction nasale

Question 71

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Patient âgé de 28 ans, victime de brûlures thermiques par flammes suite à un accident domestique lui occasionnant des brûlures de 2ème degré superficiel intéressant la tête et le cou et du 3ème degré intéressant le tronc antérieur et postérieur.

1/ La surface cutanée brûlée de ce patient est de :

☐ a.

35%

☐ b.

18%

☐ c.

27%

☐ d.

45%

☐ e.

16%

Feedback

La réponse correcte est : 45%

Question 72

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ L'unité de brûlure standard de ce patient est de :

☐ a.

45%

☐ b.

81%

☐ c.

27%

☐ d.

153%

☐ e.

63%

Feedback

La réponse correcte est : 153%

Question 73

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique : Vous êtes devant une patiente âgée de 65 ans, ayant comme seul antécédent un cancer du sein sous chimiothérapie. Elle consulte pour dyspnée avec douleurs basithoraciques. À l'examen: tachycardia à 100bpm, PA= 80/60 mmHg, FR= 24 c/mn, SpO2= 88%, auscultation: éclat de β_2 au foyer pulmonaire, turgescence des jugulaires, diurèse à 50cc/h, marbrures des genoux. Voici son ECG. 1/ Le tracé ECG montre:

☐ a.

Une tachycardia sinusale

☐ b.

Un bloc de branche gauche complet

☐ c.

Un sous décalage du segment ST en inférieur

☐ d.

Un aspect S1 Q3

☐ e.

Une onde P pulmonaire

Feedback

Les réponses correctes sont : Une tachycardia sinusale, Un aspect S1 Q3

Question 74

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ La prise en charge immediate comprend:

☐ a.

Un remplissage avec des cristalloides à 30 ml/kg/30mn

☐ b.

Oxygénothérapie à haut debit

☐ c.

Bolus héparinothérapie

☐ d.

Mise sous noradrenaline

☐ e.

Réalisation d'une échographie cardiaque

Feedback

Les réponses correctes sont : Oxygénothérapie à haut debit, Bolus héparinothérapie, Mise sous noradrenaline, Réalisation d'une échographie cardiaque

Question 75

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Le tableau Clinique évoque:

☐ a.

Un état de choc septique à porte d'entrée pulmonaire

☐ b.

Un état de choc cardiogénique suite à une tamponade cardiaque

☐ c.

Un état de choc cardiogénique suite à une embolie pulmonaire

☐ d.

Une pneumopathie grave communautaire

☐ e.

Un état de choc anaphylactique

Feedback

La réponse correcte est : Un état de choc cardiogénique suite à une embolie pulmonaire

Question 76

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Amine, âgé de 7 mois, est ramené aux urgences pour diarrhées profuses évoluant depuis 3 jours.

A l'examen : Poids = 7500g, Température = 39°, Fréquence cardiaque = 140/min, TA= 92/59 mmHg, Temps de recoloration = 2", Fréquence respiratoire = 50 cycles/min.

1/ Calculez le pourcentage de perte de poids chez Amine qui pesait au dernier contrôle il ya 10 jours 8200g

☐ a.

10%

☐ b.

5%

☐ c.

8.5%

☐ d.

9%

☐ e.

8.2%

Feedback

La réponse correcte est : 8.5%

Question 77

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Préciser le stade de déshydratation

☐ a.

Déshydratation stade 3

☐ b.

Déshydratation stade 1

☐ c.

Déshydratation stade 2

☐ d.

Déshydratation sévère

☐ e.

Déshydratation modérée

Feedback

Les réponses correctes sont : Déshydratation stade 2, Déshydratation modérée

Question 78

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Quels sont les principes de prise en charge de ce nourrisson au cours des premières 4 heures

☐ a.

Evaluation du retentissement hydro-électrolytique (ionogramme + fonction rénale)

☐ b.

Evaluation du retentissement acido-basique (Gaz du sang).

☐ c.

Administration de la moitié des pertes (350 ml) par une solution isotonique

☐ d.

Surveillance des signes de déshydratation

☐ e.

Correction du déficit sodé

Feedback

Les réponses correctes sont : Evaluation du retentissement hydro-électrolytique (ionogramme + fonction rénale), Evaluation du retentissement acido-basique (Gaz du sang), Administration de la moitié des pertes (350 ml) par une solution isotonique, Surveillance des signes de déshydratation

Question 79

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mme A.M, âgée de 32 ans, est adressée en endocrinologie pour une hypercholestérolémie à 2,2 g/L. Elle n'a aucune plainte fonctionnelle.

Antécédents personnels : La patiente est suivie en gynécologie pour un syndrome des ovaires polykystiques.

Antécédents familiaux : Hypertension artérielle et dyslipidémie chez la mère.

A l'examen physique : Poids = 72 kg ; taille = 168 cm ; tension artérielle = 12/8 cmHg et fréquence cardiaque = 88 battements/min.

La glycémie capillaire est à 1,8 g/L.

1/ Quels sont les critères qui justifient le dépistage du diabète de type 2 chez cette patiente ?

☐ a.

L'âge

☐ b.

Les antécédents familiaux d'HTA et de dyslipidémie

☐ c.

L'antécédent personnel de syndrome des ovaires polykystiques

☐ d.

L'indice de masse corporelle

☐ e.

L'hypercholestérolémie à 2,2 g/L

Feedback

Les réponses correctes sont : L'antécédent personnel de syndrome des ovaires polykystiques,
L'indice de masse corporelle

Question 80

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Quel bilan faut-il demander en première intention pour le dépistage du diabète chez cette patiente ?

☐ a.

Une deuxième glycémie capillaire

☐ b.

Un dosage de la glycémie veineuse à jeun

☐ c.

Un dosage de l'albumine glyquée

☐ d.

Un dosage de l'insulinémie à jeun

☐ e.

Un dosage des anticorps anti-glutamate acide décarboxylase

Feedback

La réponse correcte est : Un dosage de la glycémie veineuse à jeun

Question 81

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Le diagnostic de prédiabète étant retenu, vous allez prescrire chez cette patiente:

- ☐ a.
une activité physique régulière
- ☐ b.
une réduction de 25 à 30% de l'apport calorique journalier
- ☐ c.
un inhibiteur des alpha-glucosidases
- ☐ d.
un inhibiteur des SGLT2
- ☐ e.
un dépistage du diabète tous les 3 ans

Feedback

Les réponses correctes sont : une activité physique régulière, une réduction de 25 à 30% de l'apport calorique journalier

Question 82

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Un homme âgé de 52 ans consulte pour contrôle périodique de son diabète qui évolue depuis six ans. Il n'est pas tabagique et ne consomme pas d'alcool.

A l'examen, il pèse 72 kg (taille 1,73 m), sa TA est à 150/85 mm Hg confirmée.

Un bilan sanguin, à jeun, montre:

- une glycémie à 1.6 g/l avec HbA1C = 8,5%

- une triglycéridémie à 2,8 g/l, une cholestérolémie à 1,6 g/l, un taux de HDL-C à 0,35g/l.

Le bilan de retentissement du diabète ne montre pas d'anomalies.

1/ Quelle(s) est (sont) la(les) classe(s) de lipoprotéines dont la concentration est augmentée chez notre patient ?

☐ a.

LDL

☐ b.

CHYLOMICRONS

☐ c.

VLDL

☐ d.

HDL

☐ e.

IDL

Feedback

Les réponses correctes sont : LDL, VLDL

Question 83

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Selon l'ESC 2021, notre patient :

☐ a.

Nécessite l'application du Globorisk score

☐ b.

Est à haut risque cardiovasculaire

☐ c.

Nécessite une électrophorèse des lipoprotéines

☐ d.

Est à très haut risque cardiovasculaire

☐ e.

Toutes les réponses sont justes

Feedback

La réponse correcte est : Est à haut risque cardiovasculaire

Question 84

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ La prise en charge thérapeutique spécifique de ses anomalies lipidiques comporte :

☐ a.

Une réduction pondérale

☐ b.

Une réduction des apports en acides gras trans

☐ c.

Une augmentation des apports en fibres alimentaires

☐ d.

L'usage des triglycérides à chaînes moyennes

☐ e.

L'équilibration du diabète

Feedback

Les réponses correctes sont : Une réduction des apports en acides gras trans, Une augmentation des apports en fibres alimentaires, L'équilibration du diabète

Question 85

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Un patient âgé de 34 ans, est hospitalisé en réanimation pour prise en charge d'un polytraumatisme, le bilan lésionnel montre : un traumatisme thoracique avec quelques fractures de côtes et quelques contusions pulmonaires, un traumatisme abdominal avec des contusions hépatiques(foie G) et de la rate.

Le patient a eu une splénectomie d'hémostase à l'admission.

Il est intubé, ventilé pour syndrome de détresse respiratoire aigue.

Le cinquième jour de son hospitalisation, il présente une altération brutale de son état hémodynamique avec apparition de maeléna et déglobulisation à 5g d'hémoglobine (Hb était à 10g/dl le matin).

La diurèse est de 150 cc les quatre dernières heures (poids= 75 kg).

Les lactates sont à 4.

1/ Choisir la ou les réponse(s) justes :

☐ a.

Les lactates élevés et l'hypotension artérielle sont deux éléments spécifiques au diagnostic de l'état de choc hémorragique

☐ b.

La diurèse est préservée malgré l'hypotension

☐ c.

Les contusions hépatiques sont la seule étiologie possible du saignement chez ce patient

☐ d.

Ce patient doit bénéficier d'une fibroscopie digestive à côté du scanner abdominal après stabilisation de son état hémodynamique

☐ e.

La perfusion libérale de cristalloïdes est permise en attendant l'arrivée des culots globulaires

Feedback

La réponse correcte est : Ce patient doit bénéficier d'une fibroscopie digestive à côté du scanner abdominal après stabilisation de son état hémodynamique

Question 86

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Quelle sera la conduite à tenir pour la prise en charge de cet état de choc hémorragique chez ce patient :

☐ a.

La prise d'une autre voie veineuse périphérique de bon calibre (au moins 18 G) est nécessaire

☐ b.

La réalisation d'un bilan d'hémostase complet (TP/TCA/ Fibrinogène/ D Dimères) est nécessaire afin de voir s'il y'a une CIVD ou pas et la stadifier

☐ c.

La réalisation d'une RAI avant transfusion est nécessaire si non disponible

☐ d.

La transfusion de PFC se conçoit dès qu'on ait donné deux culots globulaires (CG) avec respect du ratio 01 CG/ 01 PFC/ 01 CP (culot plaquettaire) si on est dans un protocole de transfusion massive

☐ e.

Le taux de fibrinogène doit être supérieur à 01g/L

Feedback

Les réponses correctes sont : La prise d'une autre voie veineuse périphérique de bon calibre (au moins 18 G) est nécessaire, La réalisation d'un bilan d'hémostase complet (TP/TCA/ Fibrinogène/ D Dimères) est nécessaire afin de voir s'il y'a une CIVD ou pas et la stadifier, La réalisation d'une RAI avant transfusion est nécessaire si non disponible, La transfusion de PFC se conçoit dès qu'on ait donné deux culots globulaires (CG) avec respect du ratio 01 CG/ 01 PFC/ 01 CP (culot plaquettaire) si on est dans un protocole de transfusion massive

Question 87

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Choisir la ou les réponse(s) justes :

☐ a.

Une diurèse de 0.4 cc/kg/H est satisfaisante chez ce patient pour dire qu'on ait réussi à avoir une bonne perfusion rénale

☐ b.

Le maintien d'une hypotension permissive (PA systolique à 90 mmHg) est nécessaire jusqu'au contrôle de la source de saignement

☐ c.

Le monitoring du bilan d'hémostase complet au moins deux fois par jour (le premier jour) après contrôle du saignement est nécessaire

☐ d.

La surveillance uniquement des paramètres hémodynamiques est suffisante pour détecter à temps un resaignement

☐ e.

L'optimisation de la calcémie ainsi que le réchauffement du patient sont nécessaires afin d'optimiser l'hémostase du patient

Feedback

Les réponses correctes sont : Le maintien d'une hypotension permissive (PA systolique à 90 mmHg) est nécessaire jusqu'au contrôle de la source de saignement, Le monitoring du bilan d'hémostase complet au moins deux fois par jour (le premier jour) après contrôle du saignement est nécessaire, L'optimisation de la calcémie ainsi que le réchauffement du patient sont nécessaires afin d'optimiser l'hémostase du patient

Question 88

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Un patient âgé de 70 ans aux antécédents d'hypertension artérielle traitée par Spironolactone est hospitalisé pour vomissements, vertiges, flou visuel, acouphènes et des douleurs osseuses évoluant depuis 2 mois.

A l'examen : Pâleur cutanéomuqueuse, obnubilé, paraplégie, pas d'hépatosplénomégalie ni d'adénopathies périphériques

ECG : Fc : 89 bpm, QTc : 296ms

NFS : GB = 4500/mm³ (PNN : 1600/mm³, lymphocytes : 1200/mm³, monocytes : 650/mm³)

Hb = 7.2g/dl VGM = 87 fl, TCMH = 28pg Réticulocytes : 30000/mm³

Plaquettes = 185000/mm³

CRP : 126 mg/l, Ca²⁺ = 2,53 mmol/l, créatinémie = 80μmol/l

EPP : protidémie : 130g/l, albuminémie : 21g/l, pic à base étroite migrant dans les gammaglobulines à 90g/l.

La radiographie du rachis lombaire de face et de profil montre un tassement vertébral de L4-L5 avec des géodes des corps vertébraux.

1/ Les anomalies biologiques chez ce patient sont ? :

☐ a.

Anémie normochrome normocytaire arégénérative

☐ b.

Hypoprotidémie

☐ c.

Hypercalcémie

☐ d.

Pic monoclonal des gammaglobulines

☐ e.

Monocytes élevés

Feedback

Les réponses correctes sont : Anémie normochrome normocytaire arégénérative, Hypercalcémie, Pic monoclonal des gammaglobulines

Question 89

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Les signes de gravité imminente chez ce patient :

☐ a.

Altération de l'état de conscience

☐ b.

Paraplégie

☐ c.

QTc : 296 mm

☐ d.

Syndrome inflammatoire biologique

☐ e.

Vomissements

Feedback

Les réponses correctes sont : Altération de l'état de conscience, Paraplégie, QTc : 296 mm

Question 90

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Les complications pouvant expliquer l'altération de l'état de conscience chez ce patient sont :

☐ a.

Hypercalcémie

☐ b.

Hyperprotidémie

☐ c.

Compression médullaire

☐ d.

Anémie

☐ e.

Syndrome inflammatoire biologique

Feedback

Les réponses correctes sont : Hypercalcémie, Hyperprotidémie, Anémie

Question 91

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

4/ Le diagnostic le plus probable chez ce patient :

☐ a.

Métastases osseuses

☐ b.

Myélome multiple

☐ c.

Lymphome

☐ d.

Ostéoporose

☐ e.

Surdosage en Spironolactone

Feedback

La réponse correcte est : Myélome multiple

Question 92

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

5/ Pour étayer le diagnostic, le bilan doit comporter :

☐ a.

Immunofixation sanguine et urinaire

☐ b.

Dosage de parathormone

☐ c.

Free light chain sanguin

☐ d.

Myélogramme

☐ e.

Beta2microglobuline

Feedback

Les réponses correctes sont : Immunofixation sanguine et urinaire, Free light chain sanguin, Myélogramme

Question 93

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mme AC âgée de 40 ans consulte pour des douleurs cervicales associées à un état subfébrile (température mesurée entre 37,5 et 38 °), des palpitations, des frissons et une diarrhée.

A l'examen : TA : 12/6 cmHg – Pouls : 100 b/min - Goitre stade II homogène, douloureux à la palpation, absence d'adénopathies cervicales.

A la biologie : FT4 : 2,28 ng/dl (0,7-1,5) - TSH : 0,006 mUI/L (0,5-5) - CRP: 60 mg/l – NFS: GB: 12050/mm³ – Hb: 12,3 g/dl – Plaquettes: 498000/mm³ - ATPO<0 - Anticorps antirécepteurs de la TSH < 0.

La scintigraphie est blanche.

1/ Le tableau clinico-biologique que présente la patiente cadre avec le diagnostic de:

☐ a.

Maladie de Basedow

☐ b.

Adénome toxique

☐ c.

Thyroïdite subaiguë lymphocytaire sporadique

☐ d.

Thyroïdite subaiguë de De Quervain

☐ e.

Thyroïdite factice

Feedback

La réponse correcte est : Thyroïdite subaiguë de De Quervain

Question 94

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ L'évolution de cette affection est caractérisée par :

☐ a.

L'aggravation de l'hyperthyroïdie et sa persistance

☐ b.

L'installation ultérieure d'une orbitopathie

☐ c.

L'installation d'une hypothyroïdie périphérique chronique et définitive

☐ d.

DL'installation d'une thyroïdite inflammatoire auto-immune chronique

☐ e.

Un retour spontanée à l'euthyroïdie après une phase d'hypothyroïdie

Feedback

La réponse correcte est : Un retour spontanée à l'euthyroïdie après une phase d'hypothyroïdie

Question 95

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Le traitement de cette patiente repose sur :

☐ a.

La chirurgie

☐ b.

L'iode radioactif

☐ c.

Les antithyroïdiens de synthèse

☐ d.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les corticoïdes

☐ e.

Les bêtabloquants

Feedback

Les réponses correctes sont : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les corticoïdes, Les bêtabloquants

Question 96

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Une femme de 46 ans, suivie pour trouble bipolaire en psychiatrie sous lithium est retrouvée inconsciente dans la salle de bain.

Des boîtes vides de médicaments sont retrouvées à ses côtés.

La patiente est transférée aux urgences après trois heures.

Elle présente aux urgences trois crises convulsives tonico-cloniques généralisées sans retour à un état de conscience normal entre les crises.

Son Glasgow Coma Scale (GCS) est de 06/15. Elle présente également des tremblements, des myoclonies et un hématome sous cutané du front droit.

Le bilan biologique standard pratiqué en urgence note une insuffisance rénale avec une acidose métabolique.

Le diagnostic d'un état de mal convulsif a été retenu.

1/ Parmi les étiologies de l'état de mal convulsif, on peut évoquer :

☐ a.

Une épilepsie inaugurale.

☐ b.

Une intoxication au monoxyde de carbone

☐ c.

Une intoxication par une benzodiazépine

☐ d.

Une intoxication par le lithium

☐ e.

Un traumatisme crânien

Feedback

Les réponses correctes sont : Une intoxication au monoxyde de carbone, Une intoxication par le lithium, Un traumatisme crânien

Question 97

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic sont :

☐ a.

Un électrocardiogramme

☐ b.

Une radiographie du Thorax

☐ c.

Un dosage de la lithémie

☐ d.

Un dosage de l'HbCO.

☐ e.

Une TDM cérébrale

Feedback

Les réponses correctes sont : Un dosage de la lithémie, Un dosage de l'HbCO., Une TDM cérébrale

Question 98

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Le diagnostic d'une intoxication au lithium a été retenu. La prise en charge initiale non spécifique comporte :

☐ a.

Intubation et ventilation mécanique

☐ b.

Lavage Gastrique

☐ c.

Charbon activé

☐ d.

Eventilation non Invasive

☐ e.

Surveillance des fonctions vitales

Feedback

Les réponses correctes sont : Intubation et ventilation mécanique, Surveillance des fonctions vitales

Question 99

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

4/ La prise en charge spécifique comporte : :

☐ a.

Flumazénil

☐ b.

Naloxone

☐ c.

Immunoglobulines

☐ d.

Sels de bicarbonate molaires

☐ e.

Hémodialyse conventionnelle

Feedback

La réponse correcte est : Hémodialyse conventionnelle

Question 100

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Une jeune femme de 28 ans, enceinte à 28 semaines d'aménorrhée, consulte dans le cadre de son contrôle mensuel avec un examen cyto bactériologique des urines positif à E. coli à noter qu'elle est asymptomatique.

Le diagnostic d'une bactériurie asymptomatique est retenu.

1/ Le seuil de la bactériurie au cours de la bactériurie asymptomatique de la femme enceinte est de :

☐ a.

10² UFC

☐ b.

10³ UFC

☐ c.

10⁴ UFC

☐ d.

10⁵ UFC

☐ e.

10 UFC

Feedback

La réponse correcte est : 10⁵ UFC

Question 101

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Parmi les antibiotiques suivants, lesquels peuvent être prescrits dans cette situation

☐ a.

La fosfomycine-trométamol

☐ b.

La pivmicilliname

☐ c.

L'ofloxacine

☐ d.

Le triméthoprim-sulfaméthoxazole

☐ e.

Le cefixime

Feedback

Les réponses correctes sont : La fosfomycine-trométamol, La pivmicilliname, Le cefixime

Question 102

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Chez cette patiente

☐ a.

Il faut faire un ECBU de contrôle tous les 15 jours jusqu'à l'accouchement

☐ b.

Il faut faire un ECBU de contrôle tous les mois jusqu'à l'accouchement

☐ c.

Il faut faire un seul ECBU de contrôle à 36 semaines d'aménorrhée

☐ d.

L'ECBU de contrôle n'est pas indiqué

☐ e.

L'ECBU de contrôle est indiqué en cas d'accouchement par voie basse

Feedback

La réponse correcte est : Il faut faire un ECBU de contrôle tous les mois jusqu'à l'accouchement

Question 103

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Un patient âgé de 55 ans, consulte pour altération de l'état général évoluant depuis 2 mois à type d'amaigrissement chiffre à 15 kg.

A l'examen: polyadénopathie cervicale bilatérale et symétrique, Splénomégalie à 6 cm du rebord costal, ictère cutanéomuqueux.

A la biologie: NFS= GB=155000 (PNN 7%, Lc87%); Hb=8,5 g/dl, VGM=104, TCMH=30 pg, CCMH=34%; Rétic=180 000/mm³, PLQ=250000/mm³

LDH=850 UI/L (VN < 180 UI/L)

Bilirubine totale à 65 mmol/l (VN< 17), Bili directe=4 mmol/l

Le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique est suspecté.

1/ La numération formule sanguine révèle une ou plusieurs des anomalies suivantes :

☐ a.

Hyperleucocytose avec une lymphocytose

☐ b.

Neutropénie

☐ c.

Thrombopénie

☐ d.

Anémie arégénérative

☐ e.

Anémie macrocytaire

Feedback

Les réponses correctes sont : Hyperleucocytose avec une lymphocytose, Anémie macrocytaire

Question 104

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Citer la ou les examens permettant de retenir le diagnostic :

☐ a.

Myélogramme

☐ b.

Immunophénotypage des lymphocytes circulants

☐ c.

Etude moléculaire

☐ d.

Biopsie ganglionnaire

☐ e.

Ponction ganglionnaire

Feedback

La réponse correcte est : Immunophénotypage des lymphocytes circulants

Question 105

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Quelle(s) complication(s) suspectez-vous chez ce malade :

☐ a.

Anémie hémolytique auto-immune

☐ b.

Syndrome cave supérieur

☐ c.

Syndrome de lyse tumorale

☐ d.

Thrombopénie immunologique

☐ e.

Maladie des agglutinines froides

Feedback

La réponse correcte est : Anémie hémolytique auto-immune

Question 106

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Homme de 65 ans victime d'un accident de la voie publique : piéton heurté par un véhicule léger avec notion d'éjection, il est amené aux urgences par la Protection Civile.

A l'examen aux urgences :

Une fréquence respiratoire à 14 cycles/minute, une saturation pulsée en oxygène à 95 % à l'air ambiant avec une ampliation thoracique normale.

A l'auscultation pulmonaire les murmures vésiculaires sont bien perçus et symétriques.

La pression artérielle est à 140/75 mm Hg, une fréquence cardiaque à 75 battements/mn.

L'examen neurologique : GCS =8/15.

Au bilan lésionnel : Plaie du scalp, temporale gauche, de 1 cm entourée d'un hématome d'environ 3 cm.

1/ Les autres éléments de l'évaluation clinique de la gravité chez ce patient :

☐ a.

Etat des pupilles

☐ b.

Les signes de localisation

☐ c.

Glycémie au doigt

☐ d.

Etude des réflexes du tronc cérébral

☐ e.

Recherche de lésions extra-crâniennes

Feedback

Les réponses correctes sont : Etat des pupilles, Les signes de localisation, Etude des réflexes du tronc cérébral, Recherche de lésions extra-crâniennes

Question 107

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

2/ Le reste de l'examen trouve : Pupilles en anisocorie, pas des signes de localisation.
L'examen complémentaire à prescrire chez ce patient :

☐ a.

Scanner cérébral

☐ b.

Doppler transcrânien

☐ c.

Radiographie du rachis cervical

☐ d.

Angiographie cérébrale

☐ e.

IRM cérébrale

Feedback

La réponse correcte est : Scanner cérébral

Question 108

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

3/ Un scanner cérébral a été réalisé pour ce patient ci-joint le compte rendu :
Hyperdensité spontanée en lentille biconvexe
Votre diagnostic :

☐ a.

Hématome sous-dural

☐ b.

Hémorragie méningée

☐ c.

Contusion intracérébrale

☐ d.

Hématome extra-dural

☐ e.

Hémorragie sous arachnoïdienne

Feedback

La réponse correcte est : Hématome extra-dural

Question 109

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

4/ Votre conduite thérapeutique pour ce patient :

☐ a.

Osmothérapie

☐ b.

Antibiothérapie

☐ c.

Avis neurochirurgie

☐ d.

Drainage thoracique

☐ e.

Lutter contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS)

Feedback

Les réponses correctes sont : Osmothérapie, Avis neurochirurgie, Lutter contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS)

Question 110

Terminé

Noté sur 1,00

Marquer la question

Texte de la question

5/ Les ACSOS qui peuvent aggraver les lésions primaires :

☐ a.

Hypercapnie

☐ b.

Hypertension

☐ c.

Anémie

☐ d.

Œdème cérébral

☐ e.

Hydrocéphalie

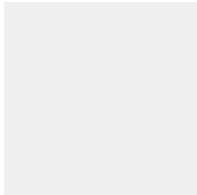
Feedback

Les réponses correctes sont : Hypercapnie, Hypertension, Anémie

Question 1

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Parmi les propositions suivantes concernant les MAPI possibles du vaccin anti coquelucheux , précisez celles qui sont justes :

☐ a.

Un syndrome des cris persistants

☐ b.

Une éruption cutanée non urticarienne 5jours après la vaccination

☐ c.

Un état de choc vagal quelques heures après la vaccination

☐ d.

Une crise convulsive

☐ e.

Une névrite brachiale

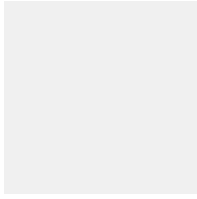
Feedback

Les réponses correctes sont : Un syndrome des cris persistants, Un état de choc vagal quelques heures après la vaccination, Une crise convulsive

Question 2

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Parmi les causes possibles d'une hématurie terminale, vous retenez ?

☐ a.

une lithiase vésicale

☐ b.

une tumeur pyélique

☐ c.

un adénome de la prostate

☐ d.

un cancer de la prostate

☐ e.

une cystite

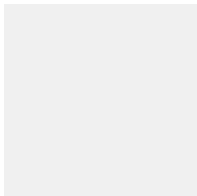
Feedback

Les réponses correctes sont : une lithiase vésicale,
une cystite

Question 3

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

L'origine de la thyroïdite du post-partum est :

☐ a.

Infectieuse

☐ b.

Carentielle

☐ c.

Toxique

☐ d.

Auto-immune

☐ e.

Idiopathique

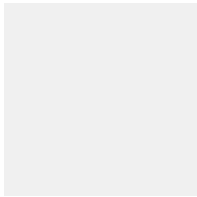
Feedback

La réponse correcte est : Auto-immune

Question 4

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une hypothyroïdie périphérique peut s'associer à:

☐ a.

Une hyperuricémie

☐ b.

Une Hypocholestérolémie

☐ c.

Une Anémie

☐ d.

Une hypercalcémie

☐ e.

Une augmentation de TSH

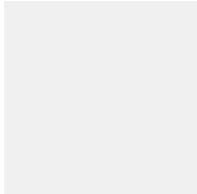
Feedback

Les réponses correctes sont : Une hyperuricémie, Une Anémie, Une augmentation de TSH

Question 5

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

La base du crâne est formée par les structures osseuses suivantes :

☐ a.

L'os pariétal

☐ b.

L'os sphénoïdal

☐ c.

L'os maxillaire

☐ d.

L'os occipital

☐ e.

L'os frontal

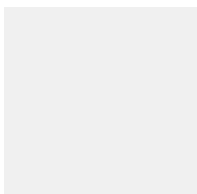
Feedback

Les réponses correctes sont : L'os pariétal, L'os sphénoïdal, L'os occipital, L'os frontal

Question 6

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

L'hématome extradural :

☐ a.

Se constitue entre l'arachnoïde et la dure-mère

☐ b.

Sa présentation au scanner est celle d'un croissant

☐ c.

Le diagnostic est suspecté à l'échographie trans-fontanellaire

☐ d.

Sa présentation au scanner est celle d'une lentille biconvexe spontanément hyperdense

☐ e.

L'examen des pupilles montre une anisocorie

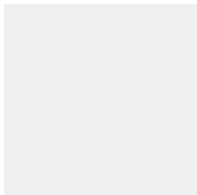
Feedback

Les réponses correctes sont : Sa présentation au scanner est celle d'une lentille biconvexe spontanément hyperdense, L'examen des pupilles montre une anisocorie

Question 7

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Au cours de l'intoxication aux organophosphorés :

☐ a.

Il existe une activation de l'activité acétyl-cholinestérasique

☐ b.

La phosphorylation du site estérasique de l'acétylcholinestérase est d'emblée irréversible

☐ c.

Il existe une accumulation d'acétylcholine

☐ d.

Il existe une hydrolyse de l'acétylcholine en choline et en acide acétique

☐ e.

Certains organophosphorés peuvent phosphoryler une protéine du système nerveux central, la neuropathytargetesterase (NTE)

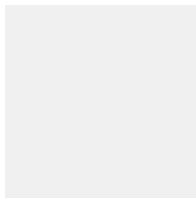
Feedback

Les réponses correctes sont : Il existe une accumulation d'acétylcholine, Certains organophosphorés peuvent phosphoryler une protéine du système nerveux central, la neuropathytargetesterase (NTE)

Question 8

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) peut survenir suite à :

☐ a.

Une combustion complète d'une matière carbonée en présence d'oxygène

☐ b.

La survenue d'un incendie

☐ c.

L'explosion d'une bouteille à gaz

☐ d.

L'exposition à un brasero dans une chambre non aérée.

☐ e.

Une fuite de gaz de ville

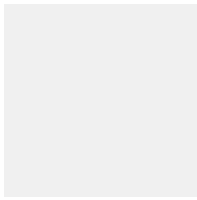
Feedback

Les réponses correctes sont : La survenue d'un incendie, L'exposition à un brasero dans une chambre non aérée.

Question 9

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

La maladie de Basedow est :

☐ a.

La première cause d'hyperthyroïdie chez le sujet âgé

☐ b.

Plus fréquente chez la femme

☐ c.

Associée à une orbitopathie dans plus de 90% des cas

☐ d.

Associée à une scintigraphie blanche

☐ e.

Associée à un taux effondré de thyroglobuline

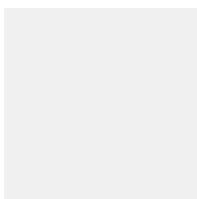
Feedback

La réponse correcte est : Plus fréquente chez la femme

Question 10

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Parmi les affections pancréatiques suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui peut (peuvent) être responsable(s) d'un diabète secondaire ?

☐ a.

La mucoviscidose

☐ b.

L'insulinome

☐ c.

La pancréatite aiguë

☐ d.

Le pancréas divisum

☐ e.

Le gastrinome

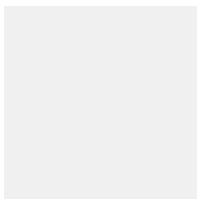
Feedback

Les réponses correctes sont : La mucoviscidose, La pancréatite aiguë

Question 11

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une HGPO75, pratiquée chez une femme enceinte à 26 semaines d'aménorrhée, montre :

Glycémie à jeun : 0,96 g/l

Glycémie 1 heure post-charge : 1,74 g/l

Glycémie 2 heures post-charge : 1,42 g/l

Cette patiente présente :

☐ a.

Une intolérance au glucose

☐ b.

Une tolérance glucidique normale

☐ c.

Une seule glycémie pathologique

☐ d.

Un diabète gestationnel

☐ e.

Un prédiabète

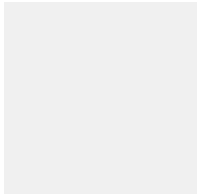
Feedback

Les réponses correctes sont : Une seule glycémie pathologique, Un diabète gestationnel

Question 12

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

La ponction articulaire lors d'une suspicion d'arthrite septique de la hanche :

☐ a.

Est indiquée avant l'échographie de la hanche

☐ b.

Est pratiquée au lit du patient

☐ c.

Doit précéder le démarrage d'une antibiothérapie

☐ d.

Renseigne notamment sur l'aspect du liquide articulaire

☐ e.

Peut déboucher immédiatement sur une arthrotomie

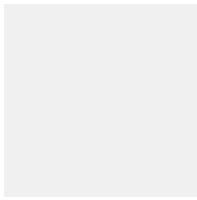
Feedback

Les réponses correctes sont : Doit précéder le démarrage d'une antibiothérapie, Renseigne notamment sur l'aspect du liquide articulaire, Peut déboucher immédiatement sur une arthrotomie

Question 13

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les deux virus les plus incriminés dans la bronchiolite aigue du nourrisson sont :

☐ a.

Le rhinovirus

☐ b.

Le virus influenzae

☐ c.

Le virus respiratoire syncitial

☐ d.

Le coronavirus

☐ e.

Le métapneumovirus

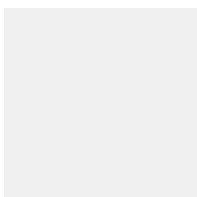
Feedback

Les réponses correctes sont : Le rhinovirus, Le virus respiratoire syncitial

Question 14

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Au cours du choc cardiogénique, lesquelles des molécules suivantes peuvent être indiquée :

☐ a.

La noradrénaline

☐ b.

Le lévosimendan

☐ c.

Une corticothérapie systémique

☐ d.

L'adrénaline

☐ e.

Les diurétiques thiazidiques

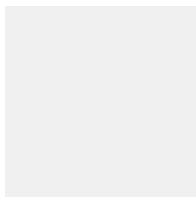
Feedback

Les réponses correctes sont : La noradrénaline, Le lévosimendan, L'adrénaline

Question 15

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Quels renseignements peut-on tirer de la Pression artérielle pulmonaire d'occlusion (PAPO) ?

☐ a.

Estimation de la post charge du VD

☐ b.

Estimation de la pré-charge du VG

☐ c.

Une PAPO élevée et un débit cardiaque bas est en faveur d'un état de choc hypovolémique

☐ d.

Est un indice de précharge cardiaque

☐ e.

Une PAPO élevée et un débit cardiaque élevée est en faveur d'un état de choc cardiogénique

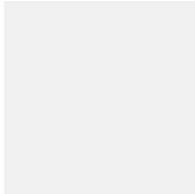
Feedback

Les réponses correctes sont : Estimation de la pré-charge du VG, Est un indice de précharge cardiaque

Question 16

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant l'hypertrophie bénigne de la prostate, quels sont les propositions justes ?

☐ a.

Il s'agit d'une tumeur bénigne

☐ b.

C'est la maladie la plus fréquente de l'homme vieillissant

☐ c.

elle se développe à partir de la zone périphérique de la prostate

☐ d.

Elle est caractérisée par le développement de plusieurs nodules adéno-fibreux

☐ e.

Peut dégénérer et entraîner un cancer de la prostate

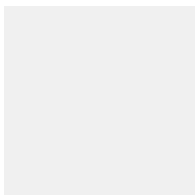
Feedback

Les réponses correctes sont : Il s'agit d'une tumeur bénigne, C'est la maladie la plus fréquente de l'homme vieillissant, Elle est caractérisée par le développement de plusieurs nodules adéno-fibreux

Question 17

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le traitement chirurgical de l'hypertrophie bénigne de la prostate peut se compliquer de :

☐ a.

Saignement post opératoire immédiat

☐ b.

Éjaculation prématurée

☐ c.

Dysfonction érectile organique

☐ d.

Saignement par chute d'escarre

☐ e.

Incontinence urinaire

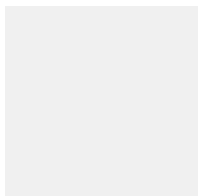
Feedback

Les réponses correctes sont : Saignement post opératoire immédiat, Saignement par chute d'escarre, Incontinence urinaire

Question 18

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Au cours de la réanimation de l'insuffisance surrénalienne aiguë, l'hydrocortisone :

☐ a.

Est administré par voie intramusculaire ou intraveineuse

☐ b.

Est administré en une seule prise par jour

☐ c.

Doit être associé au fludrocortisone le premier jour

☐ d.

Est prescrit à une dose de 50 mg à 100 mg par jour

☐ e.

Est relayé par la dexaméthazone après la normalisation de la kaliémie

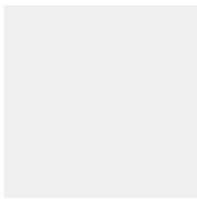
Feedback

La réponse correcte est : Est administré par voie intramusculaire ou intraveineuse

Question 19

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les signes en faveur d'une insuffisance surrénalienne d'origine périphériques sont :

☐ a.

La mélanodermie

☐ b.

L'hypotension orthostatique

☐ c.

L'hyperglycémie

☐ d.

L'hypernatrémie

☐ e.

L'hypokaliémie

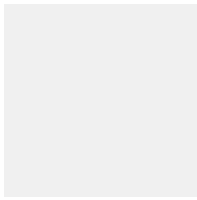
Feedback

Les réponses correctes sont : La mélanodermie, L'hypotension orthostatique

Question 20

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant la réabsorption proximale de HCO_3^- :

☐ a.

Elle est sous la dépendance de l'activité de la Na/K ATPase basolatérale

☐ b.

Elle diminue en cas d'acidose

☐ c.

Elle augmente en cas de déshydratation extracellulaire

☐ d.

L'excrétion nette des ions H^+ est nulle au niveau du TCP

☐ e.

Une baisse de la PaCO_2 conduit à une diminution de la réabsorption des bicarbonates

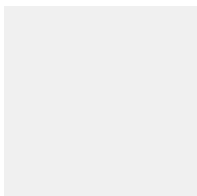
Feedback

Les réponses correctes sont : Elle est sous la dépendance de l'activité de la Na/K ATPase basolatérale, Elle augmente en cas de déshydratation extracellulaire, Une baisse de la PaCO_2 conduit à une diminution de la réabsorption des bicarbonates

Question 21

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant l'excrétion de la charge acide :

☐ a.

L'acidité titrable est la principale voie d'élimination

☐ b.

Le pH des urines dépend de la concentration des protons

☐ c.

L'excrétion urinaire de NH_4^+ est fixe

☐ d.

L'hyperkaliémie augmente la production de NH_3

☐ e.

Le tampon phosphate constitue la forme majoritaire d'acidité titrable

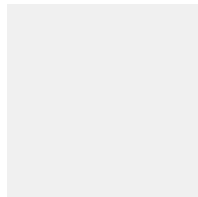
Feedback

Les réponses correctes sont : Le pH des urines dépend de la concentration des protons, Le tampon phosphate constitue la forme majoritaire d'acidité titrable

Question 22

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant la chaîne de survie lors de la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire :

☐ a.

Le premier maillon consiste en une identification et un appel des secours (alerte)

☐ b.

L'appel du SAMU au 190 fera intervenir une ambulance médicalisée

☐ c.

Evaluer la respiration et la circulation prend généralement 25 à 30 secondes

☐ d.

La présence de gasps est assimilée à une respiration anormale

☐ e.

L'absence de pouls radial signe un arrêt circulatoire

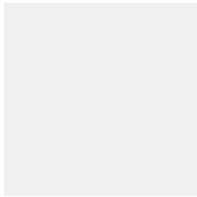
Feedback

Les réponses correctes sont : Le premier maillon consiste en une identification et un appel des secours (alerte), L'appel du SAMU au 190 fera intervenir une ambulance médicalisée, La présence de gasps est assimilée à une respiration anormale

Question 23

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les cellules du nœud auriculo-ventriculaire:

☐ a.

Ne sont pas des cellules contractiles

☐ b.

Sont dépendantes de canaux calcique et sodique rapides

☐ c.

Ont un potentiel d'action long ce qui prolonge leur période réfractaire

☐ d.

N'ont pas de dépolarisation spontanée

☐ e.

Prendent le relais en cas de défaillance du nœud sinusal

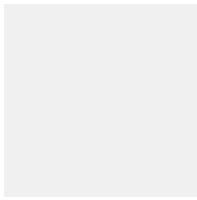
Feedback

Les réponses correctes sont : Ne sont pas des cellules contractiles, Ont un potentiel d'action long ce qui prolonge leur période réfractaire, Prendent le relais en cas de défaillance du nœud sinusal

Question 24

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le cancer de la prostate classé T2b :

☐ a.

Découvert devant un taux de P.S.A. pathologique

☐ b.

Cancer touchant plus de la moitié d'un lobe de la prostate sans toucher l'autre lobe

☐ c.

Cancer touchant les 2 lobes de la prostate

☐ d.

Cancer touchant un lobe de la prostate et la vésicule séminale homolatérale

☐ e.

Cancer découvert sur du matériel de résection endoscopique de prostate (plus de 5% réséqué)

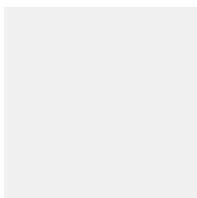
Feedback

La réponse correcte est : Cancer touchant plus de la moitié d'un lobe de la prostate sans toucher l'autre lobe

Question 25

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le score de Gleason dans le cancer de la prostate est basé sur :

☐ a.

l'architecture de la tumeur

☐ b.

l'index mitotique

☐ c.

l'invasion vasculaire.

☐ d.

La présence d'un granulome avec des cellules géantes

☐ e.

L'engainement péri-nerveux

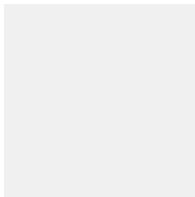
Feedback

La réponse correcte est : l'architecture de la tumeur

Question 26

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une patiente âgée de 32 ans, hospitalisée en réanimation, présente à l'examen neurologique une ouverture et fermeture des yeux selon un rythme circadien, une présence de tous les réflexes du tronc et une respiration spontanée.

Par ailleurs, elle n'obéit pas aux ordres et ne réagit pas à la stimulation nociceptive.

La patiente présente :

☐ a.

Un coma

☐ b.

Un état de conscience minimal

☐ c.

Un état d'éveil non-répondant

☐ d.

Une mort encéphalique

☐ e.

Un locked in syndrome

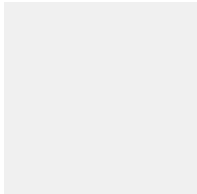
Feedback

La réponse correcte est : Un état d'éveil non-répondant

Question 27

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant les antalgiques de pallier 2 :

☐ a.

Ils ne sont prescrits qu'en deuxième intention (après ceux du pallier 1)

☐ b.

Provoquent souvent une accélération du transit

☐ c.

Possèdent des actions synergiques avec le paracétamol

☐ d.

Induisent une réduction de l'efficacité des AVK

☐ e.

L'association avec la morphine est synergique

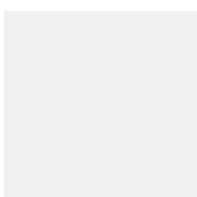
Feedback

La réponse correcte est : Possèdent des actions synergiques avec le paracétamol

Question 28

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant les mécanismes de la douleur, relever la (ou les) réponse(s) juste(s) :

☐ a.

Les douleurs mixtes sont des douleurs à la fois nociceptives et psychogènes

☐ b.

Les douleurs par excès de nociception sont dues à un dommage tissulaire

☐ c.

La diminution de la douleur au détournement de l'attention atteste de son caractère psychogène

☐ d.

Les douleurs par excès de nociception ne sont pas influencées par les émotions

☐ e.

Le chlorhydrate de tramadol est efficace sur les douleurs neuropathiques

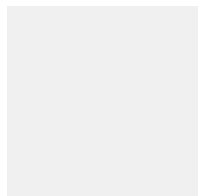
Feedback

Les réponses correctes sont : Les douleurs par excès de nociception sont dues à un dommage tissulaire, Le chlorhydrate de tramadol est efficace sur les douleurs neuropathiques

Question 29

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le facteur atrial natriurétique (FAN) :

☐ a.

Augmente la filtration glomérulaire

☐ b.

Est stimulé par l'hypervolémie centrale

☐ c.

Augmente la natriurèse par la diminution de la réabsorption de Na au niveau du Tube contourné proximal

☐ d.

Augmente la perméabilité membranaire glomérulaire en agissant sur les cellules mésangiales glomérulaires

☐ e.

Diminue la réabsorption obligatoire de l'eau au niveau du Tube contourné proximal

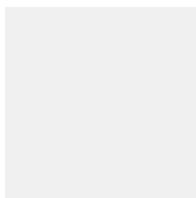
Feedback

Les réponses correctes sont : Augmente la filtration glomérulaire, Est stimulé par l'hypervolémie centrale, Augmente la natriurèse par la diminution de la réabsorption de Na au niveau du Tube contourné proximal, Augmente la perméabilité membranaire glomérulaire en agissant sur les cellules mésangiales glomérulaires

Question 30

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Lors du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire :

☐ a.

La contraception par une pilule œstro-progestative

☐ b.

Les cellules de la macula densa détectent le contenu tubulaire en NaCl

☐ c.

La sécrétion de rénine est inhibée par l'adénosine

☐ d.

Les cellules des lacis se contractent

☐ e.

L'information passe du tube distal vers le glomérule par un influx nerveux

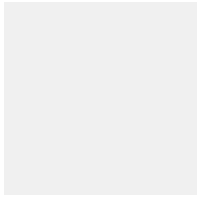
Feedback

Les réponses correctes sont : Les cellules de la macula densa détectent le contenu tubulaire en NaCl, La sécrétion de rénine est inhibée par l'adénosine

Question 31

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une pression rénale de perfusion à 60 mmHg s'accompagne de :

☐ a.

Une baisse du débit de filtration glomérulaire

☐ b.

Vasoconstriction puissante de l'Artériole afférente

☐ c.

Une augmentation du taux de NaCl dans la lumière tubulaire

☐ d.

Une augmentation de la sécrétion de rénine

☐ e.

Une diminution de l'activité sympathique

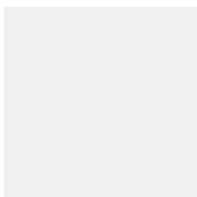
Feedback

Les réponses correctes sont : Une baisse du débit de filtration glomérulaire, Une augmentation de la sécrétion de rénine

Question 32

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Patient de 67 ans, présente une otite moyenne qui s'est rapidement associée à une céphalée, vomissements, fièvre et prostration.

Le diagnostic d'une méningite purulente a été retenu. L'interrogatoire note une prise de betalactamines dans les trois derniers mois.

Quelle est la bactérie responsable ?

☐ a.

Streptococcus pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline

☐ b.

Streptococcus pneumoniae de sensibilité conservée à la pénicilline

☐ c.

Listeria monocytogenes

☐ d.

Neisseria meningitidis

☐ e.

Streptococcus pyogenes

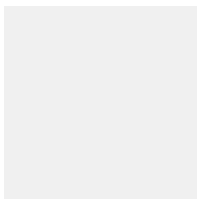
Feedback

La réponse correcte est : Streptococcus pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline

Question 33

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le(s) principal(aux) germes uréasiques est(sont):

☐ a.

E.Coli

☐ b.

Streptocoque

☐ c.

Proteus mirabilis

☐ d.

Corynébactrium D2

☐ e.

Serratia

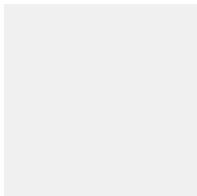
Feedback

Les réponses correctes sont : Proteus mirabilis, Corynébactrium D2, Serratia

Question 34

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une colique néphrétique est dite grave (une ou plusieurs réponses):

☐ a.

Si associée à une fièvre

☐ b.

Si elle s'accompagne de signe digestif

☐ c.

Si associée à un tableau d'anurie

☐ d.

Si associée à des signes urinaires du bas appareil

☐ e.

Chez le transplanté rénal

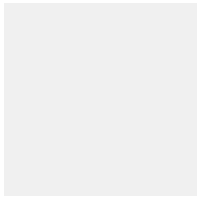
Feedback

Les réponses correctes sont : Si associée à une fièvre, Si associée à un tableau d'anurie, Chez le transplanté rénal

Question 35

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les œdèmes généralisés peuvent être expliqués par :

☐ a.

Prise médicamenteuse

☐ b.

Hypothyroïdie

☐ c.

Insuffisance cardiaque

☐ d.

Syndrome de Mikulicz

☐ e.

Dermohypodermite

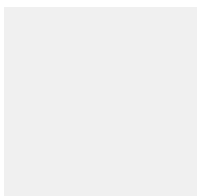
Feedback

Les réponses correctes sont : Prise médicamenteuse, Hypothyroïdie, Insuffisance cardiaque

Question 36

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Un œdème blanc, mou, prenant le godet chez un sujet âgé édenté et diabétique peut être expliqué par :

☐ a.

Une déshydratation extra cellulaire

☐ b.

Une diminution de la Pression oncotique

☐ c.

Une diminution de la perméabilité capillaire

☐ d.

Une dénutrition

☐ e.

Une hypotension artérielle

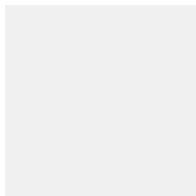
Feedback

Les réponses correctes sont : Une diminution de la Pression oncotique, Une dénutrition

Question 37

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Devant une adénopathie cervicale isolée, l'examen à demander pour confirmer une origine toxoplasmique est :

☐ a.

La recherche du parasite au niveau du liquide de ponction ganglionnaire

☐ b.

La recherche d'antigènes toxoplasmiques au niveau du liquide de ponction ganglionnaire

☐ c.

La recherche d'anticorps sériques anti-toxoplasmiques

☐ d.

La recherche d'antigènes toxoplasmiques au niveau du sérum

☐ e.

La recherche de l'ADN parasitaire au niveau du sang

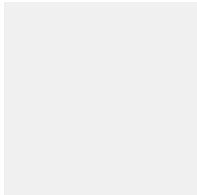
Feedback

La réponse correcte est : La recherche d'anticorps sériques anti-toxoplasmiques

Question 38

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les parasitoses considérées comme des infections sexuellement transmissibles sont :

☐ a.

La gale

☐ b.

La balano-posthite candidosique

☐ c.

La trichomonose uro-génitale

☐ d.

La bilharziose uro-génitale

☐ e.

La phtirose

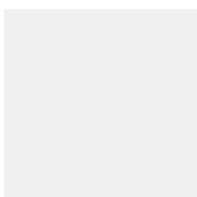
Feedback

Les réponses correctes sont : La gale, La trichomonose uro-génitale, La phtirose

Question 39

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Est considéré comme traumatisé sévère :

☐ a.

Un patient qui a une fracture des deux jambes après une chute dans un match de football

☐ b.

Un patient heurté par une voiture sur l'autoroute et dont l'examen initial trouve une déformation isolée de la jambe gauche

☐ c.

Un patient défénestré (chute du 3ème étage) mais dont l'examen clinique initial semble normal

☐ d.

Un accidenté de la voie publique dont le bilan lésionnel complet à l'hôpital montre une fracture de la 3ème et 4ème côtes droites et une fracture du bassin

☐ e.

Un conducteur présentant une plaie du scalp suite à un avp ayant entraîné le décès du passager avant

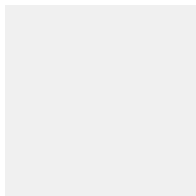
Feedback

Les réponses correctes sont : Un patient heurté par une voiture sur l'autoroute et dont l'examen initial trouve une déformation isolée de la jambe gauche, Un patient défénestré (chute du 3ème étage) mais dont l'examen clinique initial semble normal, Un accidenté de la voie publique dont le bilan lésionnel complet à l'hôpital montre une fracture de la 3ème et 4ème côtes droites et une fracture du bassin, Un conducteur présentant une plaie du scalp suite à un avp ayant entraîné le décès du passager avant

Question 40

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Parmi ces indications, les quelles nécessitent une intubation oro-trachéale immédiate en cas de polytraumatisme ?

☐ a.

Détresse circulatoire

☐ b.

Détresse neurologique avec un GCS ≤ 8

☐ c.

Patient traumatisé avec un arrachement de membre

☐ d.

En cas de brûlure de la face

☐ e.

Détresse respiratoire en rapport avec un pneumothorax

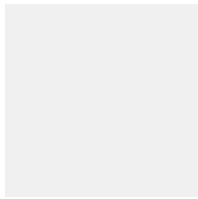
Feedback

Les réponses correctes sont : Détresse neurologique avec un GCS ≤ 8 , Patient traumatisé avec un arrachement de membre, En cas de brûlure de la face

Question 41

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Chez une femme de 62 ans, l'apparition de douleurs inflammatoires progressives des épaules avec enraidissement douloureux associées à des radiographies normales, doit faire évoquer 2 diagnostics parmi les suivants :

☐ a.

Goutte

☐ b.

Spondylarthrite

☐ c.

Tendinopathie

☐ d.

Polyarthrite rhumatoïde

☐ e.

Pseudopolyarthrite rhizomélique

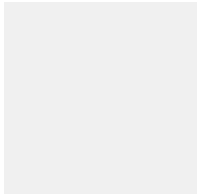
Feedback

Les réponses correctes sont : Polyarthrite rhumatoïde, Pseudopolyarthrite rhizomélique

Question 42

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Devant le tableau de polyarthrite rhumatoïde récente, isolée chez une femme de 27 ans, les explorations suivantes sont toutes justifiées d'emblée sauf une, laquelle :

☐ a.

Radiographie articulaire

☐ b.

Recherche du facteur rhumatoïde

☐ c.

Radiographie du thorax

☐ d.

Tomodensitométrie des sacro-iliaques

☐ e.

Recherche des Ac anti-nucléaires

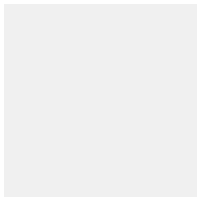
Feedback

La réponse correcte est : Tomodensitométrie des sacro-iliaques

Question 43

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les anticorps anti-CCP sont :

☐ a.

De mauvais pronostic quand ils sont positifs à titre élevé

☐ b.

Dirigés contre des peptides riches en citrulline

☐ c.

Très spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde

☐ d.

Très peu sensibles

☐ e.

Dosés en routine en technique ELISA

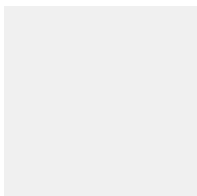
Feedback

Les réponses correctes sont : De mauvais pronostic quand ils sont positifs à titre élevé, Dirigés contre des peptides riches en citrulline, Très spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, Dosés en routine en technique ELISA

Question 44

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le purpura vasculaire de mécanisme non inflammatoire peut être dû à :

☐ a.

Une Constitution de microthrombi dans la lumière vasculaire

☐ b.

Des anomalies qualitatives des plaquettes

☐ c.

Un dépôt de complexes immuns

☐ d.

Une migration d'embols

☐ e.

Une fragilité vasculaire secondaire à une amylose

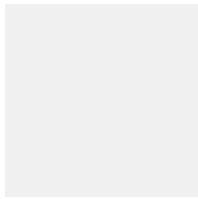
Feedback

Les réponses correctes sont : Une Constitution de microthrombi dans la lumière vasculaire, Une migration d'embols, Une fragilité vasculaire secondaire à une amylose

Question 45

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les pathologies pouvant causer un purpura vasculaire sont :

☐ a.

Lupus érythémateux systémique

☐ b.

Hépatite virale C

☐ c.

Connectivite mixte

☐ d.

Cancer du poumon

☐ e.

Hypovitaminose A

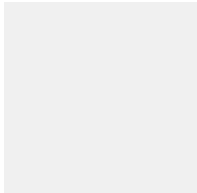
Feedback

Les réponses correctes sont : Lupus érythémateux systémique, Hépatite virale C, Connectivite mixte, Cancer du poumon

Question 46

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

La métallo-protéase ADAMTS13 clive spécifiquement :

☐ a.

Le Facteur VII de la coagulation

☐ b.

Le Fibrinogène

☐ c.

Le plasminogène

☐ d.

Le Facteur Willebrand

☐ e.

Le Facteur VIII

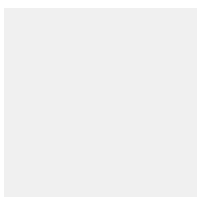
Feedback

La réponse correcte est : Le Facteur Willebrand

Question 47

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les situations pouvant se manifester par un purpura thrombopathique sont :

☐ a.

La maladie de Bernard Soulier

☐ b.

L'Insuffisance rénale chronique

☐ c.

L'Insuffisance hépato-cellulaire

☐ d.

Purpura post transfusionnel

☐ e.

La prise d'AINS

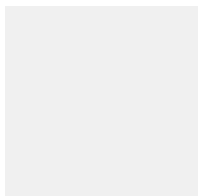
Feedback

Les réponses correctes sont : La maladie de Bernard Soulier, L'Insuffisance rénale chronique, L'Insuffisance hépato-cellulaire, La prise d'AINS

Question 48

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le phénotype D partiel :

☐ a.

Anomalie quantitative de l'antigène RHD

☐ b.

Immunogène

☐ c.

Peut être découvert suite à une discordance dans le groupage Rhésus D

☐ d.

Peut être découvert suite à la découverte d'un anticorps anti D chez un sujet D négatif

☐ e.

Exprimé à la surface des plaquettes

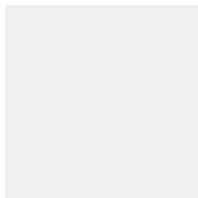
Feedback

Les réponses correctes sont : Immunogène, Peut être découvert suite à une discordance dans le groupage Rhésus D

Question 49

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Le test de Coombs direct est :

☐ a.

Test globulaire

☐ b.

Test en deux temps

☐ c.

Nécessite l'usage d'antiglobuline

☐ d.

Indiqué dans l'enquête d'un accident transfusionnel de type allergique

☐ e.

Indiqué dans l'enquête d'un accident transfusionnel de type hémolyse

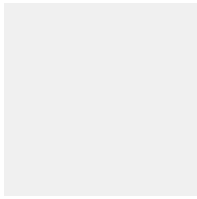
Feedback

Les réponses correctes sont : Test globulaire, Nécessite l'usage d'antiglobuline, Indiqué dans l'enquête d'un accident transfusionnel de type hémolyse

Question 50

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Les hémolysines sont :

☐ a.

Dangereux en transfusion

☐ b.

Des Anticorps naturels

☐ c.

De nature IgM

☐ d.

Traversent la barrière foetoplacentaire

☐ e.

Peu hémolysants

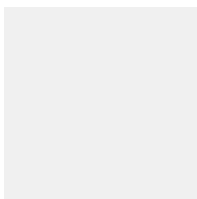
Feedback

Les réponses correctes sont : Dangereux en transfusion, Traversent la barrière foetoplacentaire

Question 51

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Concernant l'action de l'aldostérone au niveau du tubule rénal, quelle(s) est (sont) la (les) propositions qui sont exactes :

☐ a.

L'aldostérone stimule l'antiport Na/H au niveau du tube contourné proximal afin d'augmenter la réabsorption du sodium

☐ b.

L'aldostérone stimule les canaux potassique ROMK au niveau de la branche ascendante large de l'anse de henlé

☐ c.

L'aldostérone augmente l'activité de canal épithélial sodique au niveau de la cellule principale

☐ d.

L'aldostérone stimule la pompe H/K ATP asique au niveau de la cellule intercalaire A

☐ e.

L'aldostérone stimule directement les canaux potassiques au niveau de la cellule intercalaire B

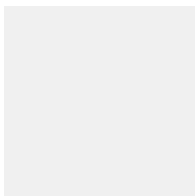
Feedback

La réponse correcte est : L'aldostérone augmente l'activité de canal épithélial sodique au niveau de la cellule principale

Question 52

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une acidose métabolique avec une hyperkaliémie s'observe au cours de :

☐ a.

Vomissements abondants

☐ b.

Insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/m

☐ c.

Diarrhée

☐ d.

Une insuffisance surrénalienne

☐ e.

Un traitement par diurétique de l'anse

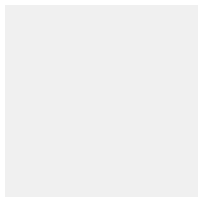
Feedback

Les réponses correctes sont : Insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/m, Une insuffisance surrénalienne

Question 53

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Parmi les propositions suivantes, précisez celles qui sont justes :

☐ a.

Le vaccin anti coquelucheux acellulaire est un vaccin inactivé

☐ b.

Le vaccin anti rabique est un vaccin vivant atténué

☐ c.

Le vaccin anti pneumococcique (PVC10) est un vaccin recombinant

☐ d.

Le vaccin anti rotavirus est un vaccin vivant atténué

☐ e.

Le vaccin anti diphtérique est une anatoxine

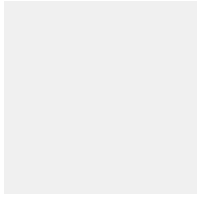
Feedback

Les réponses correctes sont : Le vaccin anti rotavirus est un vaccin vivant atténué, Le vaccin anti diphtérique est une anatoxine

Question 54

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mr x, âgé de 30 ans hypertendu sous aldomet, consulte pour syndrome anémique fonctionnel avec ictère évoluant depuis une semaine.

A l'examen, pâleur cutanéomuqueuse avec ictère franc. Il a une SMG à 3cm. L'état hémodynamique est stable.

NFS : GB : 12000/mm³ (9000 de PNN)

Hb : 6g/dl, VGM : 82fl, Réticulocytes : 140000/mm³

Plq : 540000/mm³

Bilirubine totale : 40mmol/l (VN < 15mmol/l), Bilirubine directe : 7mmol/l

LDH : 500U/l (VN : 180U/l)

Créat : 60μmol/l

1/ Quels sont les arguments en faveur de l'hémolyse intratissulaire ? :

☐ a.

Triade : pâleur, ictère et splénomégalie

☐ b.

Hybilirubinémie libre

☐ c.

Anémie régénérative

☐ d.

Thrombocytose

☐ e.

Elévation des LDH

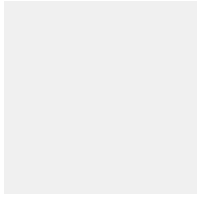
Feedback

Les réponses correctes sont : Triade : pâleur, ictère et splénomégalie, Hybilirubinémie libre, Elévation des LDH

Question 55

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Quels sont les deux examens à demander afin de préciser le mécanisme de cette anémie hémolytique ? :

☐ a.

Frottis sanguin

☐ b.

Test de Coombs direct

☐ c.

Dosage de l'haptoglobine

☐ d.

Electrophorèse de l'hémoglobine

☐ e.

Myélogramme

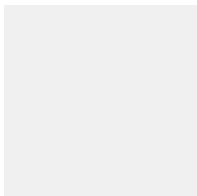
Feedback

Les réponses correctes sont : Frottis sanguin, Test de Coombs direct

Question 56

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Le diagnostic d'une anémie hémolytique auto-immune est retenu. Quelle est l'étiologie la plus probable ? :

☐ a.

Idiopathique

☐ b.

Prise médicamenteuse

☐ c.

Infection virale

☐ d.

Transfusion

☐ e.

Maladie de système

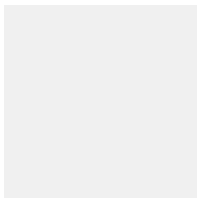
Feedback

La réponse correcte est : Prise médicamenteuse

Question 57

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

4/ Quelle serait votre conduite à tenir ? :

☐ a.

Arrêt de l'aldomet

☐ b.

Transfusion

☐ c.

Corticothérapie

☐ d.

Supplémentation en folates

☐ e.

Abstention

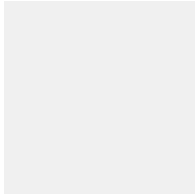
Feedback

Les réponses correctes sont : Arrêt de l'aldomet, Supplémentation en folates

Question 58

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mr Y, de 70 ans suivi pour ACFA sous traitement adressé par son cardiologue pour prise en charge d'une anémie.

A l'examen, le patient est pâle, tachycarde à 100bpm et polyénique à 28C/mn. Des OMI ont été objectivés. Il n'y a pas de syndrome tumoral.

NFS : GB : 4500/mm³ (PNN : 2100/mm³)

Hb : 7g/dl, VGM : 90fl, Rétic : 65000/mm³

Plq : 110000/mm³

Créat : 70μmol/l

Bilan hépatique normal

Dosage vitamine B12 et Folates normal

1/ Devant ce tableau, quel est le diagnostic le plus probable ? :

☐ a.

Syndrome myélodysplasique

☐ b.

Carence en vitamine B12

☐ c.

Carence en Folates

☐ d.

Hépatopathie chronique

☐ e.

Insuffisance rénale

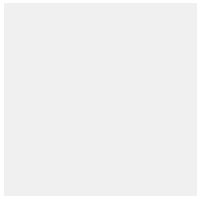
Feedback

La réponse correcte est : Syndrome myélodysplasique

Question 59

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Quel est l'examen à réaliser pour confirmer le diagnostic ? :

☐ a.

Myélogramme

☐ b.

Frottis sanguin

☐ c.

Dosage de l'haptoglobine

☐ d.

Test de Coombs direct

☐ e.

Electrophorèse de l'Hb

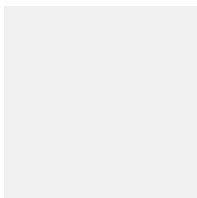
Feedback

La réponse correcte est : Myélogramme

Question 60

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Il s'agit d'un syndrome myélodysplasique, quelle serait votre conduite à tenir ? :

☐ a.

Transfusion en urgences devant les signes d'insuffisance cardiaque droite

☐ b.

Corticothérapie

☐ c.

Supplémentation en fer

☐ d.

Supplémentation vitaminique

☐ e.

Abstention

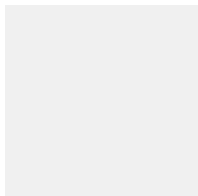
Feedback

La réponse correcte est : Transfusion en urgences devant les signes d'insuffisance cardiaque droite

Question 61

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Un patient âgé de 30 ans est victime d'un accident de sport entraînant une fracture ouverte de la jambe droite.

L'examen retrouve une déformation de la jambe avec une plaie de 01 cm simple non contuse en regard de la déformation.

La radiographie de la jambe montre une fracture spiroïde médio-diaphysaire du tibia et une fracture du col de la fibula.

1/ Cette fracture ouverte de jambe :

☐ a.

Est une fracture ouverte de dehors en dedans

☐ b.

Est une fracture ouverte de dedans en dehors

☐ c.

Est classée Cauchoix et Duparc I

☐ d.

Est classée Cauchoix et Duparc II

☐ e.

Est à haut risque de lésion nerveuse

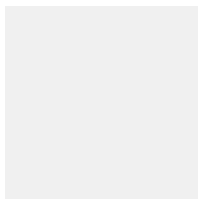
Feedback

Les réponses correctes sont : Est une fracture ouverte de dedans en dehors, Est classée Cauchoix et Duparc I, Est à haut risque de lésion nerveuse

Question 62

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Le traitement à faire aux urgences :

☐ a.

Démarrer une antibiothérapie

☐ b.

Sérothérapie et vaccination antitétanique

☐ c.

Un parage de la plaie

☐ d.

Un lavage abondant de la plaie

☐ e.

La mise en place d'un fixateur externe

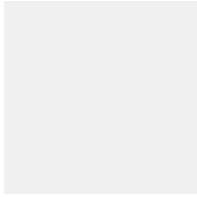
Feedback

Les réponses correctes sont : Démarrer une antibiothérapie, Sérothérapie et vaccination antitétanique, Un lavage abondant de la plaie

Question 63

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Vous décidez d'opérer le patient 04 heures après son traumatisme, le traitement à faire au bloc opératoire :

☐ a.

Un parage et une suture de la plaie

☐ b.

La mise en place d'un fixateur externe

☐ c.

Une ostéosynthèse par un clou centromédullaire

☐ d.

La confection d'un plâtre cruro-pédieux

☐ e.

Un lambeau de couverture de la perte de substance cutanée

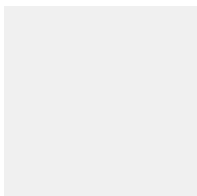
Feedback

Les réponses correctes sont : Un parage et une suture de la plaie, Une ostéosynthèse par un clou centromédullaire, Un lambeau de couverture de la perte de substance cutanée

Question 64

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

4/ Deux jours après l'intervention, lors de la visite, vous suspectez un syndrome aigu des loges, les signes cliniques en faveurs sont :

☐ a.

Une abolition des pouls distaux

☐ b.

Une bradycardie

☐ c.

Une douleur à l'extension des orteils

☐ d.

Une tension excessive du mollet

☐ e.

Des paresthésies au niveau des orteils

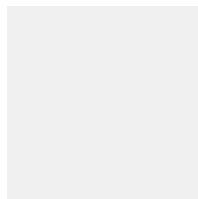
Feedback

Les réponses correctes sont : Une douleur à l'extension des orteils, Une tension excessive du mollet, Des paresthésies au niveau des orteils

Question 65

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

MNourrisson de 18 mois amené par ses parents pour refus d'appui du côté droit depuis 24h.

A l'examen, température à 39°C, état général conservé, impotence fonctionnelle du membre inférieur droit avec douleur à la mobilisation de la hanche.

1/ Devant ce tableau quels sont les diagnostics les plus probables ? :

☐ a.

Rhume de la hanche

☐ b.

Arthrite septique de la hanche

☐ c.

Rhumatisme articulaire aiguë

☐ d.

Ostéomyélite du col fémoral

☐ e.

Arthrite inflammatoire de la hanche

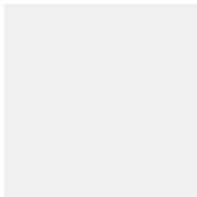
Feedback

Les réponses correctes sont : Arthrite septique de la hanche, Ostéomyélite du col fémoral

Question 66

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Quels sont les examens complémentaires que vous demandez en première intention :

☐ a.

Radiographie du bassin

☐ b.

Bilan inflammatoire (NFS, VS, CRP)

☐ c.

Un dosage des ASLO

☐ d.

Une scintigraphie osseuse

☐ e.

Une IRM

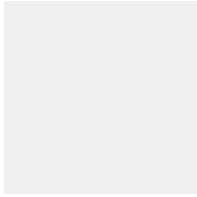
Feedback

Les réponses correctes sont : Radiographie du bassin, Bilan inflammatoire (NFS, VS, CRP)

Question 67

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Le nourrisson a un syndrome inflammatoire biologique, le bilan d'imagerie de première intention est sans anomalies.

L'échographie a montré un épanchement au niveau de la hanche droite de grande abondance

Quelle est votre conduite thérapeutique ? :

☐ a.

Hémoculture

☐ b.

Surveillance du patient à domicile avec prescription d'anti pyrétiq

☐ c.

Ponction articulaire

☐ d.

Mettre l'enfant sous traitement antibiotique par voie orale

☐ e.

Prescription de corticoïde

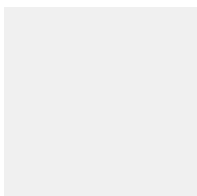
Feedback

Les réponses correctes sont : Hémoculture, Ponction articulaire

Question 68

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Nourrisson âgé de 2 mois, ancien prématuré de 32 SA, est hospitalisé pour premier épisode de dyspnée sifflante.

A l'examen physique :

Apyrétiq

FR :70 c/min

Sao2 90%

Signes de lutte marqués

Auscultation pulmonaire : râles sibilants diffus au niveau des 2 champs pulmonaires

1/ Quels sont les critères d'hospitalisation pour ce nourrisson ?

☐ a.

Le terrain

☐ b.

L'âge

☐ c.

La fréquence respiratoire

☐ d.

La saturation en O2

☐ e.

La tolérance digestive

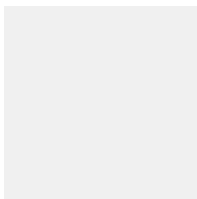
Feedback

Les réponses correctes sont : Le terrain, L'âge, La fréquence respiratoire, La saturation en O2

Question 69

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Une radiographie de thorax a été pratiquée, que peut-t-elle montrer ?

☐ a.

Une atélectasie

☐ b.

Une distension thoracique

☐ c.

Une asymétrie de transparence

☐ d.

Une cardiomégalie

☐ e.

Un pneumothorax

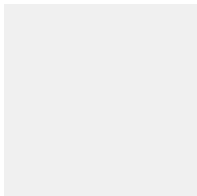
Feedback

Les réponses correctes sont : Une atélectasie, Une distension thoracique

Question 70

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Quel est le traitement à proposer pour ce nourrisson ?

☐ a.

Oxygénothérapie par lunettes nasales haut débit

☐ b.

Oxygénothérapie par lunettes nasales simples

☐ c.

Désobstruction nasale

☐ d.

Nébulisation d'adrénaline

☐ e.

Nébulisation de sérum salé hypertonique

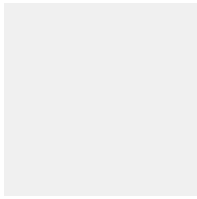
Feedback

Les réponses correctes sont : Oxygénothérapie par lunettes nasales haut débit, Oxygénothérapie par lunettes nasales simples, Désobstruction nasale

Question 71

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Patient âgé de 28 ans, victime de brulures thermiques par flammes suite à un accident domestique lui occasionnant des brulures de 2ème degré superficiel intéressant la tête et le cou et du 3ème degré intéressant le tronc antérieur et postérieur.

1/ La surface cutanée brûlée de ce patient est de :

☐ a.

35%

☐ b.

18%

☐ c.

27%

☐ d.

45%

☐ e.

16%

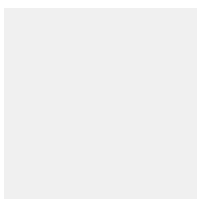
Feedback

La réponse correcte est : 45%

Question 72

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ L'unité de brûlure standard de ce patient est de :

☐ a.

45%

☐ b.

81%

☐ c.

27%

☐ d.

153%

☐ e.

63%

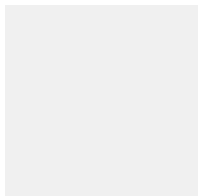
Feedback

La réponse correcte est : 153%

Question 73

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique : Vous êtes devant une patiente âgée de 65 ans, ayant comme seul antécédent un cancer du sein sous chimiothérapie. Elle consulte pour dyspnée avec douleurs basithoraciques. À l'examen: tachycardia à 100bpm, PA= 80/60 mmHg, FR= 24 c/mn, SpO2= 88%, auscultation: éclat de β_2 au foyer pulmonaire, turgescence des jugulaires, diurèse à 50cc/h, marbrures des genoux. Voici son ECG. 1/ Le tracé ECG montre:

☐ a.

Une tachycardia sinusale

☐ b.

Un bloc de branche gauche complet

☐ c.

Un sous décalage du segment ST en inférieur

☐ d.

Un aspect S1 Q3

☐ e.

Une onde P pulmonaire

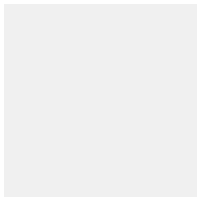
Feedback

Les réponses correctes sont : Une tachycardia sinusale, Un aspect S1 Q3

Question 74

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ La prise en charge immediate comprend:

☐ a.

Un remplissage avec des cristalloides à 30 ml/kg/30mn

☐ b.

Oxygénothérapie à haut debit

☐ c.

Bolus héparinothérapie

☐ d.

Mise sous noradrenaline

☐ e.

Réalisation d'une échographie cardiaque

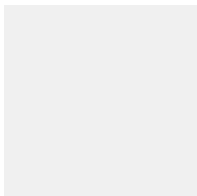
Feedback

Les réponses correctes sont : Oxygénothérapie à haut debit, Bolus héparinothérapie, Mise sous noradrenaline, Réalisation d'une échographie cardiaque

Question 75

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Le tableau Clinique évoque:

☐ a.

Un état de choc septique à porte d'entrée pulmonaire

☐ b.

Un état de choc cardiogénique suite à une tamponade cardiaque

☐ c.

Un état de choc cardiogénique suite à une embolie pulmonaire

☐ d.

Une pneumopathie grave communautaire

☐ e.

Un état de choc anaphylactique

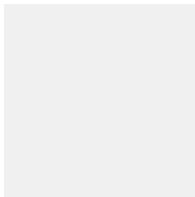
Feedback

La réponse correcte est : Un état de choc cardiogénique suite à une embolie pulmonaire

Question 76

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Amine, âgé de 7 mois, est ramené aux urgences pour diarrhées profuses évoluant depuis 3 jours.

A l'examen : Poids = 7500g, Température = 39°, Fréquence cardiaque = 140/min, TA= 92/59 mmHg, Temps de recoloration = 2'', Fréquence respiratoire = 50 cycles/min.

1/ Calculez le pourcentage de perte de poids chez Amine qui pesait au dernier contrôle il ya 10 jours 8200g

☐ a.

10%

☐ b.

5%

☐ c.

8.5%

☐ d.

9%

☐ e.

8.2%

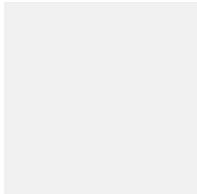
Feedback

La réponse correcte est : 8.5%

Question 77

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Préciser le stade de déshydratation

☐ a.

Déshydratation stade 3

☐ b.

Déshydratation stade 1

☐ c.

Déshydratation stade 2

☐ d.

Déshydratation sévère

☐ e.

Déshydratation modérée

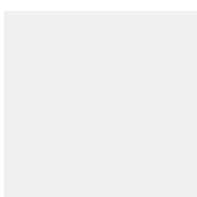
Feedback

Les réponses correctes sont : Déshydratation stade 2, Déshydratation modérée

Question 78

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Quels sont les principes de prise en charge de ce nourrisson au cours des premières 4 heures

☐ a.

Evaluation du retentissement hydro-électrolytique (ionogramme + fonction rénale)

☐ b.

Evaluation du retentissement acido-basique (Gaz du sang).

☐ c.

Administration de la moitié des pertes (350 ml) par une solution isotonique

☐ d.

Surveillance des signes de déshydratation

☐ e.

Correction du déficit sodé

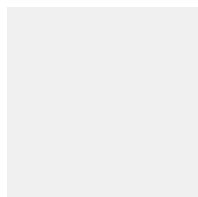
Feedback

Les réponses correctes sont : Evaluation du retentissement hydro-électrolytique (ionogramme + fonction rénale), Evaluation du retentissement acido-basique (Gaz du sang)., Administration de la moitié des pertes (350 ml) par une solution isotonique, Surveillance des signes de déshydratation

Question 79

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mme A.M, âgée de 32 ans, est adressée en endocrinologie pour une hypercholestérolémie à 2,2 g/L. Elle n'a aucune plainte fonctionnelle.

Antécédents personnels : La patiente est suivie en gynécologie pour un syndrome des ovaires polykystiques.

Antécédents familiaux : Hypertension artérielle et dyslipidémie chez la mère.

A l'examen physique : Poids = 72 kg ; taille = 168 cm ; tension artérielle = 12/8 cmHg et fréquence cardiaque = 88 battements/min.

La glycémie capillaire est à 1,8 g/L.

1/ Quels sont les critères qui justifient le dépistage du diabète de type 2 chez cette patiente ?

☐ a.

L'âge

☐ b.

Les antécédents familiaux d'HTA et de dyslipidémie

☐ c.

L'antécédent personnel de syndrome des ovaires polykystiques

☐ d.

L'indice de masse corporelle

☐ e.

L'hypercholestérolémie à 2,2 g/L

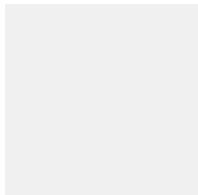
Feedback

Les réponses correctes sont : L'antécédent personnel de syndrome des ovaires polykystiques,
L'indice de masse corporelle

Question 80

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Quel bilan faut-il demander en première intention pour le dépistage du diabète chez cette patiente ?

☐ a.

Une deuxième glycémie capillaire

☐ b.

Un dosage de la glycémie veineuse à jeun

☐ c.

Un dosage de l'albumine glyquée

☐ d.

Un dosage de l'insulinémie à jeun

☐ e.

Un dosage des anticorps anti-glutamate acide décarboxylase

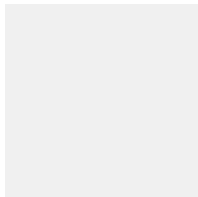
Feedback

La réponse correcte est : Un dosage de la glycémie veineuse à jeun

Question 81

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Le diagnostic de prédiabète étant retenu, vous allez prescrire chez cette patiente:

☐ a.

une activité physique régulière

☐ b.

une réduction de 25 à 30% de l'apport calorique journalier

☐ c.

un inhibiteur des alpha-glucosidases

☐ d.

un inhibiteur des SGLT2

☐ e.

un dépistage du diabète tous les 3 ans

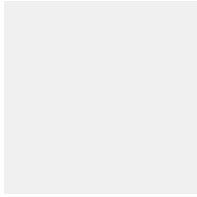
Feedback

Les réponses correctes sont : une activité physique régulière, une réduction de 25 à 30% de l'apport calorique journalier

Question 82

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Un homme âgé de 52 ans consulte pour contrôle périodique de son diabète qui évolue depuis six ans.

Il n'est pas tabagique et ne consomme pas d'alcool.

A l'examen, il pèse 72 kg (taille 1,73 m), sa TA est à 150/85 mm Hg confirmée.

Un bilan sanguin, à jeun, montre:

- une glycémie à 1.6 g/l avec HbA1C = 8,5%

- une triglycéridémie à 2,8 g/l, une cholestérolémie à 1,6 g/l, un taux de HDL-C à 0,35g/l.

Le bilan de retentissement du diabète ne montre pas d'anomalies.

1/ Quelle(s) est (sont) la(les) classe(s) de lipoprotéines dont la concentration est augmentée chez notre patient ?

☐ a.

LDL

☐ b.

CHYLOMICRONS

☐ c.

VLDL

☐ d.

HDL

☐ e.

IDL

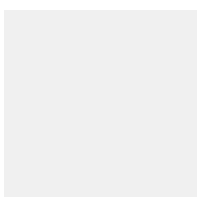
Feedback

Les réponses correctes sont : LDL, VLDL

Question 83

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Selon l'ESC 2021, notre patient :

☐ a.

Nécessite l'application du Globorisk score

☐ b.

Est à haut risque cardiovasculaire

☐ c.

Nécessite une électrophorèse des lipoprotéines

☐ d.

Est à très haut risque cardiovasculaire

☐ e.

Toutes les réponses sont justes

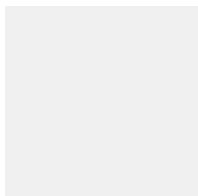
Feedback

La réponse correcte est : Est à haut risque cardiovasculaire

Question 84

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ La prise en charge thérapeutique spécifique de ses anomalies lipidiques comporte :

☐ a.

Une réduction pondérale

☐ b.

Une réduction des apports en acides gras trans

☐ c.

Une augmentation des apports en fibres alimentaires

☐ d.

L'usage des triglycérides à chaînes moyennes

☐ e.

L'équilibration du diabète

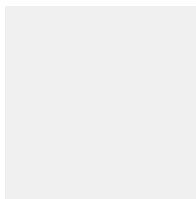
Feedback

Les réponses correctes sont : Une réduction des apports en acides gras trans, Une augmentation des apports en fibres alimentaires, L'équilibration du diabète

Question 85

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Un patient âgé de 34 ans, est hospitalisé en réanimation pour prise en charge d'un polytraumatisme, le bilan lésionnel montre : un traumatisme thoracique avec quelques fractures de côtes et quelques contusions pulmonaires, un traumatisme abdominal avec des contusions hépatiques(foie G) et de la rate.

Le patient a eu une splénectomie d'hémostase à l'admission.

Il est intubé, ventilé pour syndrome de détresse respiratoire aigue.

Le cinquième jour de son hospitalisation, il présente une altération brutale de son état hémodynamique avec apparition de maeléna et déglobulisation à 5g d'hémoglobine (Hb était à 10g/dl le matin).

La diurèse est de 150 cc les quatre dernières heures (poids= 75 kg).

Les lactates sont à 4.

1/ Choisir la ou les réponse(s) justes :

☐ a.

Les lactates élevés et l'hypotension artérielle sont deux éléments spécifiques au diagnostic de l'état de choc hémorragique

☐ b.

La diurèse est préservée malgré l'hypotension

☐ c.

Les contusions hépatiques sont la seule étiologie possible du saignement chez ce patient

☐ d.

Ce patient doit bénéficier d'une fibroscopie digestive à côté du scanner abdominal après stabilisation de son état hémodynamique

☐ e.

La perfusion libérale de cristalloïdes est permise en attendant l'arrivée des culots globulaires

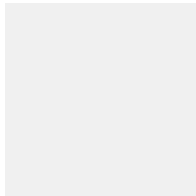
Feedback

La réponse correcte est : Ce patient doit bénéficier d'une fibroscopie digestive à côté du scanner abdominal après stabilisation de son état hémodynamique

Question 86

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Quelle sera la conduite à tenir pour la prise en charge de cet état de choc hémorragique chez ce patient :

☐ a.

La prise d'une autre voie veineuse périphérique de bon calibre (au moins 18 G) est nécessaire

☐ b.

La réalisation d'un bilan d'hémostase complet (TP/TCA/ Fibrinogène/ D Dimères) est nécessaire afin de voir s'il y'a une CIVD ou pas et la stadifier

☐ c.

La réalisation d'une RAI avant transfusion est nécessaire si non disponible

☐ d.

La transfusion de PFC se conçoit dès qu'on ait donné deux culots globulaires (CG) avec respect du ratio 01 CG/ 01 PFC/ 01 CP (culot plaquettaire) si on est dans un protocole de transfusion massive

☐ e.

Le taux de fibrinogène doit être supérieur à 01g/L

Feedback

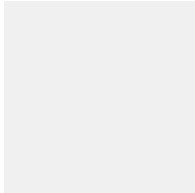
Les réponses correctes sont : La prise d'une autre voie veineuse périphérique de bon calibre (au moins 18 G) est nécessaire, La réalisation d'un bilan d'hémostase complet (TP/TCA/ Fibrinogène/ D Dimères) est nécessaire afin de voir s'il y'a une CIVD ou pas et la stadifier, La réalisation d'une RAI

avant transfusion est nécessaire si non disponible, La transfusion de PFC se conçoit dès qu'on ait donné deux culots globulaires (CG) avec respect du ratio 01 CG/ 01 PFC/ 01 CP (culot plaquettaire) si on est dans un protocole de transfusion massive

Question 87

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Choisir la ou les réponse(s) justes :

☐ a.

Une diurèse de 0.4 cc/kg/H est satisfaisante chez ce patient pour dire qu'on ait réussi à avoir une bonne perfusion rénale

☐ b.

Le maintien d'une hypotension permissive (PA systolique à 90 mmHg) est nécessaire jusqu'au contrôle de la source de saignement

☐ c.

Le monitoring du bilan d'hémostase complet au moins deux fois par jour (le premier jour) après contrôle du saignement est nécessaire

☐ d.

La surveillance uniquement des paramètres hémodynamiques est suffisante pour détecter à temps un resaignement

☐ e.

L'optimisation de la calcémie ainsi que le réchauffement du patient sont nécessaires afin d'optimiser l'hémostase du patient

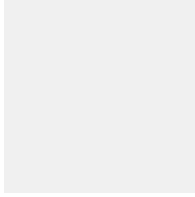
Feedback

Les réponses correctes sont : Le maintien d'une hypotension permissive (PA systolique à 90 mmHg) est nécessaire jusqu'au contrôle de la source de saignement, Le monitoring du bilan d'hémostase complet au moins deux fois par jour (le premier jour) après contrôle du saignement est nécessaire, L'optimisation de la calcémie ainsi que le réchauffement du patient sont nécessaires afin d'optimiser l'hémostase du patient

Question 88

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Un patient âgé de 70 ans aux antécédents d'hypertension artérielle traitée par Spironolactone est hospitalisé pour vomissements, vertiges, flou visuel, acouphènes et des douleurs osseuses évoluant depuis 2 mois.

A l'examen : Pâleur cutanéomuqueuse, obnubilé, paraplégie, pas d'hépatosplénomégalie ni d'adénopathies périphériques

ECG : Fc : 89 bpm, QTc : 296mm

NFS : GB = 4500/mm³ (PNN : 1600/mm³, lymphocytes : 1200/mm³, monocytes : 650/mm³)

Hb= 7.2g/dl VGM= 87 fl, TCMH=28pg Réticulocytes : 30000/mm³

Plaquettes= 185000/mm³

CRP : 126 mg/l, Ca²⁺= 2,53 mmol/l, créatinémie= 80μmol/l

EPP : protidémie : 130g/l, albuminémie : 21g/l, pic à base étroite migrant dans les gammaglobulines à 90g/l.

La radiographie du rachis lombaire de face et de profil montre un tassement vertébral de L4-L5 avec des géodes des corps vertébraux.

1/ Les anomalies biologiques chez ce patient sont ? :

☐ a.

Anémie normochrome normocytaire arégénérative

☐ b.

Hypoprotidémie

☐ c.

Hypercalcémie

☐ d.

Pic monoclonal des gammaglobulines

☐ e.

Monocytes élevés

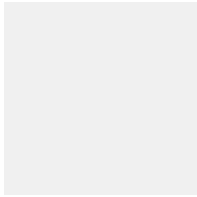
Feedback

Les réponses correctes sont : Anémie normochrome normocytaire arégénérative, Hypercalcémie, Pic monoclonal des gammaglobulines

Question 89

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Les signes de gravité imminente chez ce patient :

☐ a.

Altération de l'état de conscience

☐ b.

Paraplégie

☐ c.

QTc : 296 mm

☐ d.

Syndrome inflammatoire biologique

☐ e.

Vomissements

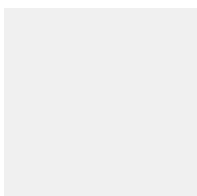
Feedback

Les réponses correctes sont : Altération de l'état de conscience, Paraplégie, QTc : 296 mm

Question 90

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Les complications pouvant expliquer l'altération de l'état de conscience chez ce patient sont :

☐ a.

Hypercalcémie

☐ b.

Hyperprotidémie

☐ c.

Compression médullaire

☐ d.

Anémie

☐ e.

Syndrome inflammatoire biologique

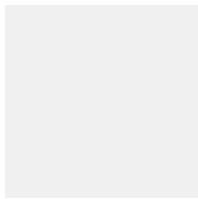
Feedback

Les réponses correctes sont : Hypercalcémie, Hyperprotidémie, Anémie

Question 91

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

4/ Le diagnostic le plus probable chez ce patient :

☐ a.

Métastases osseuses

☐ b.

Myélome multiple

☐ c.

Lymphome

☐ d.

Ostéoporose

☐ e.

Surdosage en Spironolactone

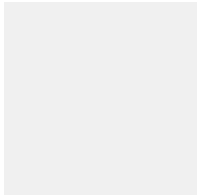
Feedback

La réponse correcte est : Myélome multiple

Question 92

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

5/ Pour étayer le diagnostic, le bilan doit comporter :

☐ a.

Immunofixation sanguine et urinaire

☐ b.

Dosage de parathormone

☐ c.

Free light chain sanguin

☐ d.

Myélogramme

☐ e.

Beta2microglobuline

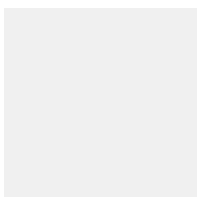
Feedback

Les réponses correctes sont : Immunofixation sanguine et urinaire, Free light chain sanguin, Myélogramme

Question 93

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Mme AC âgée de 40 ans consulte pour des douleurs cervicales associées à un état subfébrile (température mesurée entre 37,5 et 38 °), des palpitations, des frissons et une diarrhée.

A l'examen : TA : 12/6 cmHg – Pouls : 100 b/min - Goitre stade II homogène, douloureux à la palpation, absence d'adénopathies cervicales.

A la biologie : FT4 : 2,28 ng/dl (0,7-1,5) - TSH : 0,006 mUI/L (0,5-5) - CRP: 60 mg/l – NFS: GB: 12050/mm³ – Hb: 12,3 g/dl – Plaquettes: 498000/mm³ - ATPO<0 - Anticorps antirécepteurs de la TSH < 0.

La scintigraphie est blanche.

1/ Le tableau clinico-biologique que présente la patiente cadre avec le diagnostic de:

☐ a.

Maladie de Basedow

☐ b.

Adénome toxique

☐ c.

Thyroïdite subaiguë lymphocytaire sporadique

☐ d.

Thyroïdite subaiguë de De Quervain

☐ e.

Thyroïdite factice

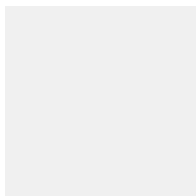
Feedback

La réponse correcte est : Thyroïdite subaiguë de De Quervain

Question 94

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ L'évolution de cette affection est caractérisée par :

☐ a.

L'aggravation de l'hyperthyroïdie et sa persistance

☐ b.

L'installation ultérieure d'une orbitopathie

☐ c.

L'installation d'une hypothyroïdie périphérique chronique et définitive

☐ d.

DL'installation d'une thyroïdite inflammatoire auto-immune chronique

☐ e.

Un retour spontanée à l'euthyroïdie après une phase d'hypothyroïdie

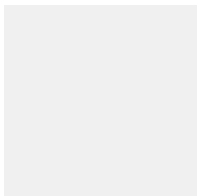
Feedback

La réponse correcte est : Un retour spontanée à l'euthyroïdie après une phase d'hypothyroïdie

Question 95

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Le traitement de cette patiente repose sur :

☐ a.

La chirurgie

☐ b.

L'iode radioactif

☐ c.

Les antithyroïdiens de synthèse

☐ d.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les corticoïdes

☐ e.

Les bêtabloquants

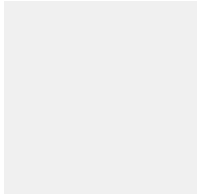
Feedback

Les réponses correctes sont : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les corticoïdes, Les bêtabloquants

Question 96

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Une femme de 46 ans, suivie pour trouble bipolaire en psychiatrie sous lithium est retrouvée inconsciente dans la salle de bain.

Des boîtes vides de médicaments sont retrouvées à ses côtés.

La patiente est transférée aux urgences après trois heures.

Elle présente aux urgences trois crises convulsives tonico-cloniques généralisées sans retour à un état de conscience normal entre les crises.

Son Glasgow Coma Scale (GCS) est de 06/15. Elle présente également des tremblements, des myoclonies et un hématome sous cutané du front droit.

Le bilan biologique standard pratiqué en urgence note une insuffisance rénale avec une acidose métabolique.

Le diagnostic d'un état de mal convulsif a été retenu.

1/ Parmi les étiologies de l'état de mal convulsif, on peut évoquer :

☐ a.

Une épilepsie inaugurale.

☐ b.

Une intoxication au monoxyde de carbone

☐ c.

Une intoxication par une benzodiazépine

☐ d.

Une intoxication par le lithium

☐ e.

Un traumatisme crânien

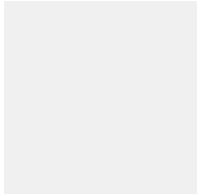
Feedback

Les réponses correctes sont : Une intoxication au monoxyde de carbone, Une intoxication par le lithium, Un traumatisme crânien

Question 97

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic sont :

☐ a.

Un électrocardiogramme

☐ b.

Une radiographie du Thorax

☐ c.

Un dosage de la lithémie

☐ d.

Un dosage de l'HbCO.

☐ e.

Une TDM cérébrale

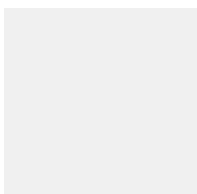
Feedback

Les réponses correctes sont : Un dosage de la lithémie, Un dosage de l'HbCO., Une TDM cérébrale

Question 98

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Le diagnostic d'une intoxication au lithium a été retenu. La prise en charge initiale non spécifique comporte :

☐ a.

Intubation et ventilation mécanique

☐ b.

Lavage Gastrique

☐ c.

Charbon activé

☐ d.

EVentilation non Invasive

☐ e.

Surveillance des fonctions vitales

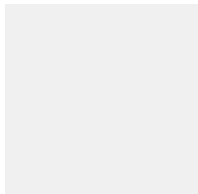
Feedback

Les réponses correctes sont : Intubation et ventilation mécanique, Surveillance des fonctions vitales

Question 99

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

4/ La prise en charge spécifique comporte : :

☐ a.

Flumazénil

☐ b.

Naloxone

☐ c.

Immunoglobulines

☐ d.

Sels de bicarbonate molaires

☐ e.

Hémodialyse conventionnelle

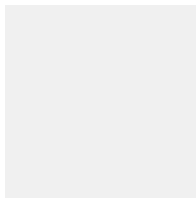
Feedback

La réponse correcte est : Hémodialyse conventionnelle

Question 100

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Une jeune femme de 28 ans, enceinte à 28 semaines d'aménorrhée, consulte dans le cadre de son contrôle mensuel avec un examen cyto bactériologique des urines positif à E. coli à noter qu'elle est asymptomatique.

Le diagnostic d'une bactériurie asymptomatique est retenu.

1/ Le seuil de la bactériurie au cours de la bactériurie asymptomatique de la femme enceinte est de :

☐ a.

10 2 UFC

☐ b.

10 3 UFC

☐ c.

10 4 UFC

☐ d.

10 5 UFC

☐ e.

10 UFC

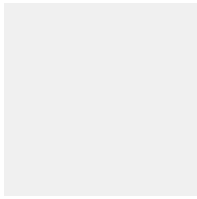
Feedback

La réponse correcte est : 10 5 UFC

Question 101

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Parmi les antibiotiques suivants, lesquels peuvent être prescrits dans cette situation

☐ a.

La fosfomycine-trométamol

☐ b.

La pivmicilliname

☐ c.

L'ofloxacine

☐ d.

Le triméthoprim-sulfaméthoxazole

☐ e.

Le cefixime

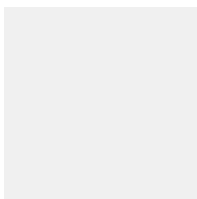
Feedback

Les réponses correctes sont : La fosfomycine-trométamol, La pivmicilliname, Le cefixime

Question 102

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Chez cette patiente

☐ a.

Il faut faire un ECBU de contrôle tous les 15 jours jusqu'à l'accouchement

☐ b.

Il faut faire un ECBU de contrôle tous les mois jusqu'à l'accouchement

☐ c.

Il faut faire un seul ECBU de contrôle à 36 semaines d'aménorrhée

☐ d.

L'ECBU de contrôle n'est pas indiqué

☐ e.

L'ECBU de contrôle est indiqué en cas d'accouchement par voie basse

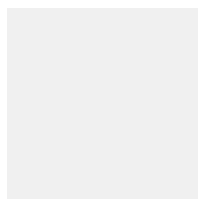
Feedback

La réponse correcte est : Il faut faire un ECBU de contrôle tous les mois jusqu'à l'accouchement

Question 103

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Un patient âgé de 55 ans, consulte pour altération de l'état général évoluant depuis 2 mois à type d'amaigrissement chiffre à 15 kg.

A l'examen: polyadénopathie cervicale bilatérale et symétrique, Splénomégalie à 6 cm du rebord costal, ictère cutanéomuqueux.

A la biologie: NFS= GB=155000 (PNN 7%, Lc87%); Hb=8,5 g/dl, VGM=104, TCMH=30 pg, CCMH=34%; Rétic=180 000/mm³, PLQ=250000/mm³

LDH=850 UI/L (VN < 180 UI/L)

Bilirubine totale à 65 mmol/l (VN< 17), Bili directe=4 mmol/l

Le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique est suspecté.

1/ La numération formule sanguine révèle une ou plusieurs des anomalies suivantes :

☐ a.

Hyperleucocytose avec une lymphocytose

☐ b.

Neutropénie

☐ c.

Thrombopénie

☐ d.

Anémie arégénérative

☐ e.

Anémie macrocytaire

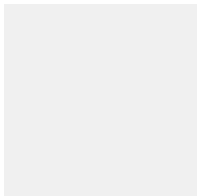
Feedback

Les réponses correctes sont : Hyperleucocytose avec une lymphocytose, Anémie macrocytaire

Question 104

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Citer la ou les examens permettant de retenir le diagnostic :

☐ a.

Myélogramme

☐ b.

Immunophénotypage des lymphocytes circulants

☐ c.

Etude moléculaire

☐ d.

Biopsie ganglionnaire

☐ e.

Ponction ganglionnaire

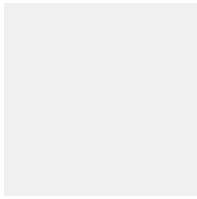
Feedback

La réponse correcte est : Immunophénotypage des lymphocytes circulants

Question 105

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Quelle(s) complication(s) suspectez-vous chez ce malade :

☐ a.

Anémie hémolytique auto-immune

☐ b.

Syndrome cave supérieur

☐ c.

Syndrome de lyse tumorale

☐ d.

Thrombopénie immunologique

☐ e.

Maladie des agglutinines froides

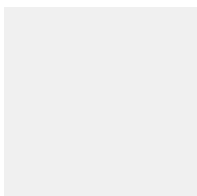
Feedback

La réponse correcte est : Anémie hémolytique auto-immune

Question 106

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

Cas clinique :

Homme de 65 ans victime d'un accident de la voie publique : piéton heurté par un véhicule léger avec notion d'éjection, il est amené aux urgences par la Protection Civile.

A l'examen aux urgences :

Une fréquence respiratoire à 14 cycles/minute, une saturation pulsée en oxygène à 95 % à l'air ambiant avec une ampliation thoracique normale.

A l'auscultation pulmonaire les murmures vésiculaires sont bien perçus et symétriques.

La pression artérielle est à 140/75 mm Hg, une fréquence cardiaque à 75 battements/mn.

L'examen neurologique : GCS =8/15.

Au bilan lésionnel : Plaie du scalp, temporale gauche, de 1 cm entourée d'un hématome d'environ 3 cm.

1/ Les autres éléments de l'évaluation clinique de la gravité chez ce patient :

☐ a.

Etat des pupilles

☐ b.

Les signes de localisation

☐ c.

Glycémie au doigt

☐ d.

Etude des réflexes du tronc cérébral

☐ e.

Recherche de lésions extra-crâniennes

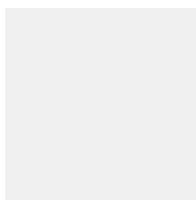
Feedback

Les réponses correctes sont : Etat des pupilles, Les signes de localisation, Etude des réflexes du tronc cérébral, Recherche de lésions extra-crâniennes

Question 107

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

2/ Le reste de l'examen trouve : Pupilles en anisocorie, pas des signes de localisation.

L'examen complémentaire à prescrire chez ce patient :

☐ a.

Scanner cérébral

☐ b.

Doppler transcrânien

☐ c.

Radiographie du rachis cervical

☐ d.

Angiographie cérébrale

☐ e.

IRM cérébrale

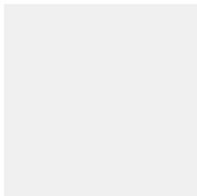
Feedback

La réponse correcte est : Scanner cérébral

Question 108

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

3/ Un scanner cérébral a été réalisé pour ce patient ci-joint le compte rendu :

Hyperdensité spontanée en lentille biconvexe

Votre diagnostic :

☐ a.

Hématome sous-dural

☐ b.

Hémorragie méningée

☐ c.

Contusion intracérébrale

☐ d.

Hématome extra-dural

☐ e.

Hémorragie sous arachnoïdienne

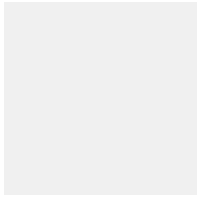
Feedback

La réponse correcte est : Hématome extra-dural

Question 109

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

4/ Votre conduite thérapeutique pour ce patient :

☐ a.

Osmothérapie

☐ b.

Antibiothérapie

☐ c.

Avis neurochirurgie

☐ d.

Drainage thoracique

☐ e.

Lutter contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS)

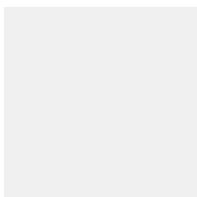
Feedback

Les réponses correctes sont : Osmothérapie, Avis neurochirurgie, Lutter contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS)

Question 110

Terminé

Noté sur 1,00



Marquer la question

Texte de la question

5/ Les ACSOS qui peuvent aggraver les lésions primaires :

☐ a.

Hypercapnie

☐ b.

Hypertension

☐ c.

Anémie

☐ d.

Œdème cérébral

☐ e.

Hydrocéphalie

Feedback

Les réponses correctes sont : Hypercapnie, Hypertension, Anémie